

Rôle Infirmier dans la prévention de la dénutrition chez les personnes âgées en milieu hospitalier et maison de repos et de soins

Travail de fin d'étude
Pour l'obtention du grade académique de
Bachelier : Infirmier Responsable de soins généraux
Par
MEGUEU TETSINA Vanette Valery
UMUGWANEZA UWASE Jeannette

Juin 2022

Remerciements

Nous tenons à remercier notre promotrice, Madame MARCHAL Audrey, pour le temps qu'elle nous a consacré afin de nous guider et de nous corriger tout au long de notre travail. Nos remerciements s'adressent également à toute l'équipe pédagogique de la Haute Ecole Robert Schuman qui nous a suivie dès le début de notre cursus jusqu'à maintenant.

Pour ma part, UMUGWANEZA UWASE Jeannette, je tiens à témoigner toute ma reconnaissance à mon binôme Vanette, pour son investissement. Enfin, je tiens à remercier mon mari NSABIMANA Léandre pour son soutien, sa disponibilité et ses encouragements envers moi durant tout mon cursus.

Moi, MEGUEU Vanette, je tiens à remercier binôme Jeannette, ma famille, mon époux et mes enfants pour leur soutien, leur encouragement ainsi que leur patience tout au long de mes années de cursus.

Mots- clés :

- Dénutrition
- Prévention
- Personne âgée

Table des matières

Introduction.....	5
1 Constats, interpellation commune et ancrage à la discipline infirmière.....	6
1.1 Constats.....	6
1.1.1 Premier constat	6
1.1.2 Deuxième constat.....	8
1.1.3 Troisième constat	10
1.2 Interpellation commune.....	11
1.3 Ancrage à la discipline infirmière	12
2 Recherches et réflexion professionnalisante	17
2.1 Exploration des concepts	17
2.1.1 Dénutrition	17
2.1.2 Prévention	21
2.1.3 Education Nutritionnelle du patient.....	30
2.2 Analyse d'un article probant	32
2.3 Enquête exploratoire.....	35
3 Synthèse, questionnement professionnel et pistes de réflexion	41
Conclusion personnelle.....	44
Liste des Références	46
Annexes.....	51

Introduction

La discipline infirmière est un domaine qui a un pôle théorique et pratique dans lequel au cours de la formation, nous réalisons des stages afin de pouvoir mettre les connaissances théoriques apprises en cours dans la pratique. Durant la quatrième année de notre cursus, nous devons réaliser un travail de fin d'étude marquant la clôture de la formation en choisissant une thématique en rapport avec une situation de stage qui nous a interpellée. Nous réaliserons ce travail en binôme sur base d'une interpellation commune que nous avons vécu durant nos stages effectués en maison de repos et de soins (MRS) et à l'hôpital. En discutant de nos vécus en stage, nous avons été interpellées par des suivis inadéquats par rapport à la dénutrition chez les personnes âgées, ce qui nous a conduit à vouloir approfondir le rôle infirmier dans la prévention de la dénutrition chez les sujets âgés institutionnalisés et/ou hospitalisés.

Dans un premier temps, nous exposerons nos trois constats par une description détaillée des situations vécues en stage. Dans le premier et deuxième constat, les situations se sont déroulées à l'hôpital, dans un service de gériatrie et le troisième constat s'est déroulé en MRS. Dans les trois constats, nous remarquerons l'installation progressive de la dénutrition chez les bénéficiaires des soins concernés. Ensuite nous démontrerons le lien entre notre questionnement et la discipline infirmière en se basant sur la démarche clinique, les compétences infirmières par rapport au référentiel de compétences professionnelles du Bachelier : Infirmier Responsable de soins généraux de la Haute Ecole Robert Schuman (HERS, 2018) et sur les points de vue réglementaire. Dans un second temps, nous effectuerons des recherches et fonderons des réflexions professionnalisantes. Nous allons commencer par choisir les concepts centraux de notre travail qui sont la dénutrition, la prévention et l'éducation à la nutrition et nous réaliserons une analyse conceptuelle en utilisant des recensions des écrits non probants et probants en lien avec nos concepts. Par la suite, nous choisirons et analyserons un article scientifique probant en lien avec notre thématique.

Ensuite, nous ferons une investigation afin de répondre à notre questionnement par la réalisation d'une enquête exploratoire dans une MRS et à l'hôpital. Le but étant de récolter des informations complémentaires provenant du terrain, afin de mieux comprendre le rôle infirmier dans la prévention de la dénutrition chez les personnes âgées. Enfin, nous réaliserons une synthèse globale de notre travail qui aboutira à un questionnement professionnel. Nous présenterons ainsi des pistes de réflexions sur base de nos recherches et notre réflexion professionnalisante et clôturerons notre travail par une conclusion personnelle.

1 Constats, interpellation commune et ancrage à la discipline infirmière

1.1 Constats

1.1.1 Premier constat

Mon premier stage de troisième année d'étude s'est passé dans un service de gériatrie où je devais prodiguer les soins à Madame C. âgée de 78 ans qui était admise dans le service pour une altération de l'état général. Madame C. résidait à domicile et avait un antécédent d'ulcère gastroduodénal. Bien qu'elle fût traitée par les inhibiteurs de la pompe à protons, pour cette pathologie, les repas jouaient aussi un rôle protecteur contre l'acidité gastrique. Elle était autonome à son domicile jusqu'au jour où elle a fait une chute qui a provoqué la dégradation de son état de santé. Lors de son admission à l'hôpital, elle pesait 53 kg pour 160 cm ce qui correspondait à un indice de masse corporelle (IMC) de 20,70 kg/m². Les normes étant comprises entre 18.5-24.9 kg/m².

Au cours de sa troisième semaine d'hospitalisation, une dénutrition s'est installée, Madame C. n'avait plus d'appétit et s'alimentait très peu. D'après une grille d'évaluation rapide du statut nutritionnel : le Mini Nutritional Risk Screening (NRS, 2002), cité dans le protocole hospitalier Vivalia par (Malempré et le CLAN, 2018), Madame C. présentait un score à quatre qui signifiait une dénutrition sévère. En l'observant cette dernière, je constate qu'elle avait maigri, présentait une faiblesse musculaire, une baisse d'énergie. À la suite de sa chute, selon les dires de Madame C., elle préférait passer ses journées au lit par peur de se mobiliser et chuter, car elle avait encore fait une chute pendant son hospitalisation, puisqu'elle ne tenait plus bien sur ses jambes. Selon Defloor *et al.* (2004). Madame C. était à risque d'escarre d'après l'échelle de Braden. Elle présentait un score de 14, la valeur adéquate étant à partir de 17. J'avais fait part de toutes mes observations aux infirmiers du service et les réponses que j'avais obtenues c'était un problème en rapport avec les modifications physiologiques liées au vieillissement avec entre autre la diminution de la sensibilité gustative (l'hypoguesie).

Bien qu'il soit formellement prévu dans le protocole de gériatrie de noter les quantités des repas consommés par les patients (relevé des ingesta) dans le but de pouvoir suivre les personnes à risque de dénutrition, il s'avère que ce phénomène reste encore mal reconnu et mal évalué dans nos hôpitaux d'après une étude de Vanderwee *et al.* (2010) réalisée chez les personnes âgées hospitalisées en Belgique.

De même lors de nos stages en milieux hospitaliers nous avons remarqué que certaines portions notées étaient des quantités erronées puisqu'il arrivait souvent aux personnels de cuisine de débarrasser les plateaux repas avant que ceux-ci soient notés.

J'avais remarqué que les préoccupations étaient plus portées sur les soins et la gestion de la médication des patients; le besoin de boire et manger était sous-estimé, pourtant selon Virginia Henderson cité par (Paget et Zara, 2016) ce besoin fait partie du deuxième besoin prioritaire qui est un besoin fondamental et vital car l'organisme pour se maintenir en bon état a besoin des nutriments pour faire fonctionner ses cellules et renouveler ses tissus or ces nutriments ne peuvent être apportés que grâce à une alimentation saine, variée, équilibrée et suffisante, ce qui n'est pas toujours le cas chez les personnes âgées.

Le jour de ma prise en charge, j'ai demandé à madame C. si elle voulait d'abord manger avant que je lui fasse les soins d'hygiène, elle m'a répondu qu'elle aimerait que je commence par les soins d'hygiène et qu'elle mangera plus tard. Pendant la toilette je l'ai pesée, elle pesait 44,3 kg ce qui lui faisait un IMC à 17,30 kg/m² inférieur aux normes. Madame C. était devenue cachexique et avait perdu 8,7 kg en trois semaines depuis son admission. Après avoir terminé les soins d'hygiène, j'ai préparé ses tartines, étant donné qu'elle était capable de manger seule, je l'ai bien installée et je suis allée faire une transmission orale et écrite. Pour donner suite à cela, une modification de l'alimentation ainsi qu'un complément alimentaire (le Fortimel®) ont été instaurés sans toutefois avoir fait une éducation sur son alimentation. À mon retour dans sa chambre, j'avais constaté qu'elle n'avait pas mangé et je lui ai fait part de cette remarque et elle m'a répondu qu'elle n'avait pas faim. Je me suis assise auprès d'elle pour la stimuler tout en lui expliquant sa situation et les risques encourus. Madame C. avait finalement mangé tout son repas et pendant qu'elle mangeait, elle m'a raconté qu'elle était inquiète pour son état de santé et que son mari est en fin de vie au domicile pendant qu'elle est hospitalisée. Elle était angoissée à l'idée de ne pas être auprès de lui pour l'accompagner dans ses derniers moments. J'étais emphatique et triste, j'ai fait une écoute active, je lui ai pris la main dans la mienne pour la réconforter tout en comprenant les raisons de sa perte d'appétit qui était en lien avec sa situation psycho-sociale-environnementale.

Trois jours après, Madame C. a reçu la visite de sa fille lui annonçant le décès de son mari, à la suite de cette nouvelle, Madame C. ne mangeait plus. Lors du rapport, concernant son cas, les infirmiers avaient déclaré que la diététicienne et le médecin traitant avaient été informés et que « ce n'était plus leur problème » car d'après eux, la dénutrition ne fait pas partie du domaine infirmier mais plutôt de celui du diététicien.

Deux jours après, le médecin a demandé de prolonger son hospitalisation afin de débiter une alimentation parentérale. Cinq jours après, l'instauration de l'alimentation parentérale, en complémentarité d'une alimentation orale, l'état de santé de Madame C. s'est amélioré ainsi que son état nutritionnel. À la suite de cette évolution, le médecin a envisagé un retour à domicile pour Madame C. Lorsque je suis entrée dans sa chambre pour lui dire aurevoir, j'ai trouvé l'infirmière qui était en train de faire une éducation à la nutrition à Madame C. et à sa fille pour un meilleur suivi du retour à domicile. Ce que j'ai trouvé fort intéressant.

1.1.2 Deuxième constat

Au cours de l'année scolaire, j'ai eu l'occasion de faire un second stage dans le service de gériatrie et je me suis occupée de Monsieur T. âgé de 75 ans qui est entré en urgence dans le service de gériatrie pour désaturation, dyspnée, toux et hyperthermie avec une infection à la covid 19. À la suite de cela, Monsieur T. était sous oxygénothérapie (masque à oxygène sur 15 litres/ minute). Monsieur T. vivait dans une MRS, avait un antécédent d'hypertension artérielle, une insuffisance respiratoire car il était un ancien fumeur et a eu un accident vasculaire cérébral (AVC) qui lui a laissé comme séquelle une hémiplégie du côté droit. Vu que Monsieur était droitier, il avait besoin d'une aide alimentaire. Monsieur T. était marié, avait un fils avec lequel il n'entretenait plus une bonne relation, mais était en contact avec son petit-fils dont il recevait régulièrement la visite. Monsieur T., dans ses habitudes de vie, avait de l'appétit et adorait les repas copieux. Mais pendant son séjour à l'hôpital, une perte de motivation pour s'alimenter s'est installée et a provoqué chez lui une baisse d'appétit. Monsieur T., à cause de la covid positif n'a pas été pesé à l'admission. Son dernier poids de référence était celui de la MRS et datait de deux ans. Dans son dossier, il pesait 90,3 kg pour 163 cm, il avait un IMC de 31,91 kg/m² et était obèse. Durant son hospitalisation, Monsieur T. s'alimentait de moins en moins certainement à cause des conditions d'isolements et des appareillages. Quand Monsieur T. retirait son masque pour manger il désaturait aussitôt à 75% d'oxygène. Il avait besoin d'une présence pour le rassurer et d'une aide lors de la prise des repas. Cette situation était difficile pour les infirmiers de pouvoir faire un suivi alimentaire car ils n'envisageaient pas la possibilité de le peser puisque Monsieur T. en plus d'être hémiplégique était en isolement et instable au niveau hémodynamique. La présence auprès de lui nécessitait un peu plus du temps car il fallait enlever le masque à oxygène et le remplacer par des lunettes lors de la prise alimentaire.

Cependant, cette pratique ne faisait pas toujours l'unanimité car certains soignants oubliaient de lui remettre le masque à la fin de la prise du repas et c'était insécurisant pour le patient dans la mesure où les lunettes ne délivraient pas de gros débit d'oxygène que nécessitait Monsieur T. pour satisfaire son besoin de respirer. Pour cette raison, d'autres préféraient soulever le masque et lui donner une petite quantité du repas ce qui diminuait son apport alimentaire. Un midi, je suis entrée dans la chambre de Monsieur T. avec son plateau repas pour lui donner à manger ; j'étais déjà informée de la problématique avec son masque à oxygène qui l'empêchait de bien s'alimenter. Pour maintenir son apport en oxygène, Pendant la prise du repas, j'avais décidé de garder son masque à oxygène et de soulever de temps en temps pour lui donner à manger. Avec de la patience, Monsieur T. avait bien mangé et était content, pendant qu'il mangeait, il m'a révélé que cela faisait longtemps qu'il n'avait plus aussi bien mangé, que lorsqu'il remarquait qu'une infirmière était pressée pour lui donner à manger, il préférait refuser car il ne voulait pas être un fardeau pour les infirmières ce qui a favorisé sa perte de motivation et sa baisse d'appétit. Cette situation le rendait malheureux, car le repas était le seul moment de plaisir pour lui et qu'il comprenait l'impatience des infirmiers à cause de leur charge de travail si importante. Depuis ce jour, Monsieur T. était content quand il constatait que je venais l'aider pour la prise de son repas. Monsieur T. avait une mobilité physique réduite, souffrait de constipation et avait un début d'escarre au niveau du talon gauche. Sur ordre médical, Monsieur T. prenait des laxatifs osmotiques pour satisfaire son besoin d'éliminer. Monsieur T. au cours de la fin de sa deuxième semaine d'hospitalisation, avait maigri mais je n'ai pas pu objectiver sa perte du poids car il n'avait jamais été pesé depuis son admission dans le service et même au cours de son hospitalisation. J'ai fait part de cette remarque aux infirmiers du service et ils m'ont répondu qu'il était hémiparétique et pour le peser, il fallait une balance spéciale et étant un service « covid », il serait compliqué d'emprunter ce genre de matériel d'un autre service.

À la fin de la troisième semaine d'hospitalisation, les résultats de sa biologie sanguine montraient que Monsieur T. avait un taux d'albuminémie (le taux d'albumine dans le sang) à 32 g/L. D'après (la Haute Autorité de Santé [HAS], 2007) ce taux était inférieur à la norme qui doit se situer au-delà de 35 g/L et signifiait que Monsieur T. présentait une dénutrition modérée. Le médecin, après l'analyse de ces résultats avait décidé de mettre en place un traitement mais Monsieur T. est décédé juste avant.

1.1.3 Troisième constat

La situation s'est déroulée dans une MRS où j'effectuais mon premier stage de troisième année. Il s'agissait de Madame L. âgée de 85 ans. C'était une personne timide, joviale et souriante. Elle se confiait difficilement, à part à quelques soignants en qui elle avait confiance. Elle avait une plaie d'escarre au sacrum. Au début de mon stage, Madame L. prenait son repas sans aide, elle mangeait toute son assiette c'est à dire, toute la viande, tous les féculents, tous les légumes, toute la soupe en plus son dessert. Au bout de trois jours de stage, elle a diminué la quantité ingurgitée lors des repas et ne mangeait plus que la moitié du contenu. Durant la deuxième semaine, Madame L. mangeait de moins à moins, c'est à dire quelques cuillères de son repas. Je l'ai signalé à l'infirmière A, qui était présente ce jour, qui m'a répondu que ce n'était pas grave, elle a ajouté que la plupart de personne âgée ne mange pas beaucoup. À la fin de la deuxième semaine, Madame L. ne mangeait quasi plus rien. Je ne me suis pas posée plus de questions comme j'avais déjà fait part de la situation à l'infirmière A. Dans cette MRS, les résidents sont pesés chaque mois. Le mois précédent, Madame L. pesait 53 kg pour 162 cm, avec un IMC de 20.2 kg/m^2 , ce dernier est normal. Lors de la pesée du mois, madame L. pesait 46 kg, avait perdu 7 kg en un mois. J'ai recalculé son IMC qui avait diminué à $17,5 \text{ kg/m}^2$, ce dernier est maigre. À la suite de cela, j'ai fait une transmission orale à l'infirmière responsable, en lui disant que selon les cours que j'ai eu et le Mini Nutritional Assessment (MNA) cité par Nestlé nutrition institute. (s.d.) , Madame L. est dénutrie et vu que l'infirmière était en train de préparer les médicaments des résidents, elle m'a dit qu'elle s'occuperait de Madame L. après son tour de médicament. Quand il y avait un peu de temps libre, je passais dans les chambres des résidents pour les écouter, discuter avec eux afin d'établir une relation de confiance. Un jour, je suis passée dans la chambre de Madame L., nous avons discuté, ce qui nous a permis d'établir une relation de confiance.

Durant la troisième semaine, je suis allée auprès d'elle pour l'aider à manger, j'étais déjà au courant qu'elle s'alimentait très peu. J'ai fait une éducation sur l'importance de manger afin d'éviter l'aggravation de sa dénutrition et le ralentissement de la cicatrisation de sa plaie d'escarre. Car Au cours de cette semaine, l'infirmière B. avait remarqué que la plaie d'escarre de Madame L. se dégradait et avait constaté une augmentation de la fibrine sur la surface de la plaie. Après ces explications, Madame L. m'a dit qu'elle comprenait mes efforts mais qu'elle n'avait toujours pas envie de manger. À force de la stimuler, elle a fini par manger la crème. En l'observant manger, j'ai remarqué qu'elle faisait des grimaces de douleurs pendant qu'elle mastiquait et déglutissait.

Je lui ai posé des questions pour en savoir plus par rapport à cette douleur, elle m'a répondu qu'elle a des douleurs en per prandial et qu'elle préfère ne pas manger pour éviter d'avoir mal. J'ai objectivé sa douleur en lui demandant où elle avait mal et depuis combien de temps ? Elle m'a répondu qu'elle avait mal dans la bouche et dans la gorge depuis un mois et que c'était une douleur permanente de type brûlure, d'une intensité de 4/10 et majorée à 7/10 quand elle déglutit. Madame L. a ajouté qu'elle est en colère parce que personne n'a été à son écoute. Je lui ai alors promis de repasser dans sa chambre pour lui apporter son antidouleur et pour observer son état buccal. Je me suis dépêchée pour aller expliquer la situation à l'infirmière A. Elle m'a donné un antidouleur (le Dafalgan®) pour Madame. Je suis allée auprès d'elle pour lui donner son antidouleur, elle était contente car elle m'a remercié avant que je sorte de sa chambre mais j'ai oublié d'observer son état buccal. Les jours passaient et l'état général de Madame L. se dégradait, elle avait développé une infection urinaire, elle avait maigri et présentait une faiblesse musculaire. Madame L. ne se tenait plus bien debout. Pendant ma dernière semaine de stage, c'est-à-dire la quatrième semaine, je me suis occupée de Madame L. pour les soins d'hygiène. En réalisant les soins de bouche, j'ai remarqué que sa cavité buccale était en mauvais état, elle avait une bouche humide avec des dépôts blanchâtres et jaunâtres à l'intérieur des joues et une inflammation de la langue qui était rouge et douloureuse. J'ai d'abord culpabilisé car je me suis rappelée qu'elle m'avait parlé de sa bouche et que j'avais oublié de regarder parce que j'étais focalisée sur l'administration de son antidouleur. En oubliant d'observer son état buccal, je n'ai pas eu l'occasion de découvrir les causes de son inappétence et prévenir ainsi sa dénutrition. Je me suis dépêchée pour appeler l'infirmière B. Cette dernière est venue la voir et était étonnée par l'état de sa bouche qui était devenu délétère sans que personne ne le remarque. À la suite de cela, le médecin traitant a été informé par l'infirmière B. et en collaboration, un traitement a été mis en place pour palier à ce problème buccal. À la fin de mon stage, l'état buccal de Madame L. s'était amélioré, elle ne présentait plus de douleur et avait retrouvé son appétit.

1.2 Interpellation commune

Au regard de toutes ces observations, il en ressort que les personnes âgées lorsqu'elles sont hospitalisées ou institutionnalisées s'alimentent peu ou presque pas pour diverses raisons, perdent du poids et sont à risque de dénutrition et/ou dénutries. En se référant à nos trois constats, nous avons remarqué que la préoccupation principale des soins était portée sur la gestion de la médication des patients. L'alimentation saine et équilibrée des personnes âgées étaient moins mise en avant.

La malnutrition de nos aînés était plutôt reliée au processus de vieillissement et était considérée comme normale donc moins priorisée. Ce qui nous a amené à une interpellation commune, qui sont **les suivis inadéquats dans la prévention de la dénutrition chez les personnes âgées dans ces lieux de stages**. Dès lors la question que nous nous posons reste celle de savoir comment les patients et résidents arrivent à cet état de dénutrition sans que celui-ci ne soit détecté de manière précoce ? D'après une recherche de Vanderwee *et al.* (2010) la dénutrition est un état qui s'installe sournoisement surtout chez les personnes âgées et augmente la morbidité et la mortalité d'autant plus qu'elle est le plus souvent totalement ignorée. D'où l'importance du rôle infirmier dans la prévention de la dénutrition.

1.3 Ancrage à la discipline infirmière

En partant de nos constats et interpellation commune, nous allons établir le lien entre notre thématique et la discipline infirmière. Pour démontrer ce lien nous allons vous exposer les différents arguments du point de vue de la démarche clinique, des compétences infirmières par rapport au référentiel de compétences professionnelles du Bachelier de la Haute Ecole Robert Schuman (HERS) : Infirmier Responsable de soins généraux et du point de vue règlementaire.

➤ Par rapport à la démarche clinique :

Nous sommes dans l'étape d'intervention. Selon (Le Neurès et Siebert, 2009), l'exécution des interventions est une étape dans laquelle l'infirmier met en œuvre le projet de soins en mobilisant les connaissances théoriques, techniques, relationnelles et son expérience en restant attentif aux réactions du patient soigné et lui permet d'accroître son autonomie et de mobiliser ses ressources personnelles. La mise en œuvre du projet de soins dont fait allusion Le Neurès ici est le fait de pouvoir mettre en application le plan établi en fonction de ce qui a été planifié pour résoudre le problème de santé identifié chez ces patients. Chaque plan de soins doit être individualisé et établi selon les résultats attendus chez le patient. Seulement ce plan établi étant en rapport avec l'alimentation et son suivi chez les patients à risque ne s'est pas appliqué de manière efficace car selon (Pascal et Frécon, 2017), le diagnostic infirmier posé ici est un problème d'alimentation déficiente et les interventions prioritaires sont une aide à la prise de poids, une assistance nutritionnelle et les conduites à tenir en cas de troubles de l'alimentation. Au regard de ces trois situations décrites ci-dessus, ces personnes âgées nécessitaient toutes un suivi régulier du poids, une quantification exacte des portions des repas consommés, une assistance et une aide alimentaire de qualité ainsi qu'une transmission efficace des informations, ce qui n'a pas été le cas.

Nos constats relatent une intervention inefficace pour prévenir la dénutrition. Elle est liée par le non-respect d'utilisation correcte des protocoles, de la banalisation de la dénutrition chez les personnes âgées, certaines limites des connaissances et le manque de transmission des informations. Dans le premier et deuxième constat, nous montrons qu'il y a des protocoles gériatriques dans le service dans le but de prévenir la dénutrition des personnes âgées. Cependant, la dénutrition ne semble pas être une priorité chez certains soignants. Ces derniers relient la dénutrition avec des modifications physiologiques liées entre autre avec le vieillissement. Cela ramène probablement à un manque de connaissance et par conséquent une intervention inefficace. Dans le troisième constat, il y a une mesure pondérale qui est faite mensuellement. Cependant, il n'y a pas de mesures qui sont mises en place en fonction des résultats obtenus. En parlant de la situation de la douleur chez Madame L. qui l'empêchait de s'alimenter à l'infirmière B, celle-ci dit qu'elle n'était pas informée alors que l'infirmière A. était au courant de la situation. Cela montre une communication infructueuse entre les membres de l'équipe soignante et de ce fait, une intervention tardive, la (HAS, 2007) précise que, plus la prise en charge est précoce, plus elle est efficace.

En résumé, l'étape de l'intervention dans la démarche clinique mentionné ci-dessus permet de mettre en exécution le plan de soin personnalisé et procéder en conséquence à une évaluation de ces interventions. Cela permet également de vérifier l'efficacité de ce plan de soins. Ainsi, en fonction des résultats obtenus, ce plan peut être soit adopté, soit révisé en cas d'échec. En se rapportant à nos constats, comme nous l'avons dit plus haut, les interventions de soins n'ont pas été exécutées avec efficience. Et dès lors, quel est donc l'intérêt de mettre en application un plan de soin si celui-ci ne peut pas être minutieusement respecté. À partir du moment où un plan de soin n'est pas adéquatement exécuté, il serait imprécis de faire une évaluation fiable à savoir si ce plan de soins nécessite d'être adopté ou révisé. Dans le cadre de notre profession infirmière, le plan de soin apparaît comme un outil de travail et relève de la démarche clinique dont l'objectif est d'identifier le problème de santé du patient et d'y répondre par l'exécution des interventions de qualité. Ce qui rentre dans des concepts centraux du Meta paradigme de notre discipline infirmière : Le soin, le patient, le soignant et l'environnement (Fawcett, 1984, cité dans Dallaire *et al.* 2021). C'est pourquoi il serait indispensable de mettre correctement en application cet outil afin d'atteindre les objectifs formulés. Cela dit, cette démarche de soins s'intègre également dans le référentiel de compétences professionnelles du Bachelier (HERS).

- À propos du référentiel de compétences professionnelles du Bachelier (HERS, 2019) : « La prévention de la dénutrition » qui est notre sujet de travail s'inscrit dans la quatrième et cinquième compétence du référentiel.

Par rapport à la quatrième compétence « concevoir de projet de soins infirmiers », la prévention de la dénutrition se trouve dans le deuxième indicateur « identifier les situations de santé, les diagnostics infirmiers et les problèmes traités en collaboration ». En nous référant aux trois constats décrits ci-dessus, le diagnostic infirmier posé est celui d'un problème d'alimentation déficiente qui se définit d'après (Pascal et Frécon, 2017) comme un « apport nutritionnel inférieur aux besoins métaboliques ». Dans le cas présent, les deux patients et la résidente de la MRS s'alimentaient très peu et leur apport nutritionnel était insuffisant à leur besoin métabolique, ceci se justifiant par la perte de poids de ces derniers.

Selon Martin *et al.* (2001) cité dans Sulmont-Rossé *et al.* (2018), pour les personnes âgées, il est recommandé d'avoir un apport calorique d'au moins 1 800 kilocalories (kcal) pour les femmes et 2 200 kcal pour les hommes de plus de 60 ans. Cependant d'après Sulmont Rossé *et al.* (2017) cité dans Sulmont Rossé *et al.* (2018), les relevés alimentaires effectués sur 24 heures dans plusieurs maisons de retraite ont montré que seulement 7% des résidents couvraient 100% de leurs besoins protéiques et caloriques. A contrario, 42% des résidents avaient des apports caloriques et/ou protéiques inférieurs au 2/3 de leurs besoins. Dans le même sens, une étude selon Bon *et al.* (2012) cité dans Sulmont Rossé *et al.* (2018) ont montré qu'à l'hôpital et en maison de retraite, la prise calorique moyenne atteignait à peine 1500 kcal par jour. Pourtant, comme le pensent Volkert *et al.* (2019), il est tout de même important de relever que certaines affections aiguës ou chroniques à l'instar des infections et la chirurgie peuvent augmenter les besoins énergétiques et précipiter la malnutrition ou la dénutrition chez les personnes âgées déjà vulnérables. (Par exemple les infections chez monsieur T. et Madame L. ainsi que les plaies d'escarres). En ce qui concerne les problèmes traités en collaboration, l'utilisation incorrecte des moyens mis en œuvre dans la prévention de la dénutrition que relève notre rôle infirmier nous a conduit dans un état curatif nécessitant les interventions d'autres acteurs pluridisciplinaires à savoir le médecin traitant, la diététicienne, la logopède et l'ergothérapeute.

Quant à la cinquième compétence « assurer une communication professionnelle », notre travail se trouve dans le premier indicateur « transmettre oralement et /ou écrit les données pertinentes en utilisant les outils de communication existants ».

Nous avons illustré dans nos constats des manquements des transmissions qui ont causé un suivi inefficace et par conséquent une dénutrition. Ainsi, le rôle infirmier dans la prévention de la dénutrition est sollicité et promulgué au niveau réglementaire.

➤ Du point de vue réglementaire

L'arrêté royal du 18 juin 1990 cité dans le protocole hospitalier Vivalia (EBN et EBM, 2018) a fixé la liste des prestations techniques des soins infirmiers parmi laquelle l'alimentation et l'hydratation entérale du patient relèvent du moins en partie de prestations de soins infirmiers « autonome » d'après la liste d'acte B1. Ce qui veut dire que l'alimentation et l'hydratation entérale relèvent du rôle propre infirmier. Cependant, l'arrêté royal a également défini la liste des activités pouvant être confiées à l'aide-soignante sous le contrôle de l'infirmière dans une équipe structurée. Parmi la liste de ces actes délégués, l'alimentation et l'hydratation par voie orale en font partie à l'exception des cas d'alimentation par sonde et de troubles de la déglutition. Ainsi, en ce qui concerne l'aide à la prise alimentaire, le suivi d'une surveillance alimentaire (relevé des ingesta) et l'hydratation orale, l'infirmière peut tout de même confier cette responsabilité à une aide-soignante, mais cela ne soustrait pas pour autant cette dernière à une observation et évaluation du travail de l'aide-soignante si l'objectif visé est la qualité des soins. D'ailleurs, en proportion de la loi coordonnée relative à l'exercice des professions de soins de santé (Loi, du 10 Mai 2015), l'analyse de la qualité des soins afin d'améliorer sa propre pratique professionnelle relève de l'accomplissement d'une des activités infirmières.

D'après le Conseil International des infirmières (CII) cité dans (Morel, 2012, p. 257).

La qualité de soins infirmiers est le degré de conformité des soins donnés par le personnel infirmier, à des normes fixées d'avance. La norme correspond au niveau à atteindre. Elle est fixée en fonction de ce qui est souhaitable pour le client et l'avancée des connaissances.

Ainsi, nous pensons que le patient a droit à des soins de qualité de la part des professionnels de santé qui respectent les objectifs à atteindre propre à chaque patient dans le but de satisfaire le besoin de ce dernier. Comme l'explique l'article cinq de l'arrêté royal du 22 Août 2002 (cité dans le moniteur Belge, 2002, p. 43719) sur le droit du patient.

Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans qu'une distinction d'aucune sorte ne soit faite.

Conformément au code de déontologie sur le droit du patient, nous constatons que l'absence de qualité de soins entraîne un manquement au droit du patient. D'après nos constats, nous avons montré qu'il y a eu des problèmes psychologiques chez Madame C., les problèmes biologiques chez Monsieur T. et de la douleur chez Madame L., ces éléments sont des facteurs favorisant de l'alimentation déficiente (Pascal et Frécon, 2017). Cependant, il y a eu un manque de prise en charge précoce de ces facteurs favorisant. Ce manquement de la part de l'équipe soignante montre l'absence des soins de qualité et la non-satisfaction des besoins du bénéficiaire des soins. En effet, le droit du patient comme stipulé dans l'arrêté royal du 22 août 2002 n'a pas été scrupuleusement respecté.

Au regard de toutes ces observations, nous pensons que notre travail a effectivement un lien avec la discipline infirmière dans la mesure où nous avons une approche scientifique qui intègre les concepts, les savoirs et les théories infirmières que nous avons besoin d'intégrer dans la pratique pour pouvoir dispenser des soins de qualité. L'exemple est l'idée de conception de la démarche clinique qui s'est inspirée des théories à larges spectres comme celle de Virginia Henderson (1994) dans la satisfaction des besoins fondamentaux du patient cité dans (Collière, 1994) ainsi que les théories à spectres moyens qui sont celles fondées sur les observations cliniques à l'instar de la théorie des symptômes indésirables de Lenz *et al.* (1997) ou de Meleis (2010) qui met en exergue la démarche clinique à travers les interventions infirmières dans la transition santé-maladie du patient. Nous avons également démontré une approche clinique dans la profession infirmière qui représente l'autre pôle de la discipline infirmière à savoir le soin auprès du patient.

2 Recherches et réflexion professionnalisante

2.1 Exploration des concepts

En s'appuyant sur nos constats et notre interpellation commune, nous avons choisi la dénutrition, la prévention et l'éducation nutritionnelle comme étant les concepts centraux de notre thématique.

Pour analyser ces concepts, nous trouvons intéressant de commencer par définir « une personne âgée » car nous développerons ces concepts en fonction de cette catégorie de personne. D'après la (HAS,2014, p.14), le « sujet âgé concerne les personnes de 65 ans et plus. ». Selon elle, l'âge du « sujet âgé » est considéré socialement comme l'âge d'arrêt d'activité professionnelle. Seulement, nous trouvons que cet âge de cessation d'activité professionnelle diffère d'une société à l'autre. D'après (le conseil d'orientation de retraite, 2019, p.2), en 2017, l'âge moyen de cessation d'activité était plus élevé pour les hommes que pour les femmes, hormis en Belgique et en France où il est quasiment identique. Cet âge est de 61,8 ans en Belgique. De ce fait, nous considérons qu'une « personne âgée » en Belgique est une personne âgée d'au moins 61,8 ans et qui n'a plus d'activité professionnelle, ce qui est le cas des trois personnes mentionnées dans nos constats. Etant donné que notre sujet d'étude se réfère à la dénutrition des personnes âgées, nous allons développer ce concept en fonction des personnes âgées hospitalisées et/ou vivant en MRS. Sur base de nos constats précités et d'expériences vécues lors des stages au cours de notre cursus, ainsi que les littératures scientifiques, nous avons remarqué que la dénutrition est fortement présente dans les institutions.

2.1.1 Dénutrition

D'après (Patry et Raynaud-Simon 2010, p.158) « La prévalence de la dénutrition est estimée à environ de 4 à 10% à domicile, de 15 à 38% en institution, et de 30 à 70% à l'hôpital ». Dans le même sens, Favors-Moreira *et al.* (2016) soulignent qu'elle est de 1 à 15% chez les personnes âgées non institutionnalisées, 25 à 60 % dans les MRS et 35 à 65% en milieux hospitalisés. Cela confirme également avec nos vécus en stage, que la dénutrition est un risque majeur pour les personnes âgées et ce risque augmente encore lorsqu'elles sont institutionnalisées et/ ou hospitalisées.

La dénutrition « se définit à travers un manque ou un déficit d'un ou de plusieurs nutriments indispensables à l'individu et qui va conduire à des changements significatifs de l'état physiologique et corporel. » Selon (Brennstuhl, 2018, s.d.).

Dans le même ordre d'idée (Busnel et Ludwig, 2018, p.55) ajoute que « ... la dénutrition est communément définie comme une diminution de l'état énergétique et/ou nutritionnel résultant d'apports alimentaires insuffisants en regard des besoins énergétiques individuels ». Par ces définitions nous constatons que l'apport alimentaire insuffisant par rapport aux besoins énergétiques provoque un déficit des nutriments et par conséquent peut entraîner une dénutrition. En revenant sur nos constats, par exemple chez Madame L. (troisième constat), nous avons remarqué que certains soignants considéraient la diminution d'apport alimentaire des personnes âgées comme un phénomène normal. Ils représentaient cette baisse d'apport alimentaire uniquement à des modifications physiologiques liées au vieillissement (altération des capacités sensorielles du goût et de l'odorat). D'après ces soignants, habituellement, « les personnes âgées ne mangent pas beaucoup ». D'une part, s'il est vrai que les modifications physiologiques liées à l'âge influencent négativement leur alimentation/nutrition, d'autre part il faut reconnaître que ce n'est pas l'unique cause. D'ailleurs, comme l'expliquent Patry et Raynaud-Simon (2010, p.158), les modifications physiologiques liées au vieillissement peuvent empêcher les personnes âgées de s'alimenter correctement, néanmoins, certaines comorbidités, qui s'augmentent de plus en plus avec l'âge influencent également l'alimentation. C'est ainsi que (Volkert *et al.*, 2019) rejoignent l'idée de Patry et Raynaud-Simon en affirmant que la diminution de l'apport alimentaire est souvent associée à une anorexie du vieillissement, mais peut également être causée par d'autres éléments tels que des difficultés dans la mastication et la déglutition, une mauvaise santé bucco-dentaire (comme dans le cas de Madame L.), l'isolement social, la solitude ou la dépression (entre autres les problèmes psychologiques chez Madame C.), des affections aiguës notamment des infections survenant sur un fond de comorbidité chronique telles que des cancers, ou encore des maladies cardiaques et respiratoires (principalement l'infection et l'insuffisance respiratoire chez monsieur T).

Par ailleurs, Patry et Raynaud-Simon (2010) expliquent que les dégradations de différents fonctionnements métaboliques associés au vieillissement et/ou certaines pathologies dont les personnes âgées souffrent, augmentent leurs besoins énergétiques. Ainsi (Martin *et al.*, 2001) cité par (ferry, 2010, p.125) ajoutent que « Les besoins nutritionnels ne sont pas diminués chez les personnes âgées, car les nutriments sont moins efficacement utilisés. » Nous pensons qu'une insuffisance des apports alimentaires peut également entraîner une perte de poids chez les patients.

En effet, le manque ou déficit des nutriments et une diminution de l'état énergétique et/ nutritionnels caractérisent la dénutrition, mais ne sont pas les seuls critères diagnostics. D'après la (HAS,2021, p.9), les critères phénotypiques de diagnostic de la dénutrition du sujet âgé de 70 ans et plus sont les suivants :

- « – Perte de poids $\geq 5 \%$ en 1 mois ou $\geq 10 \%$ en 6 mois ou $\geq 10 \%$ par rapport au poids habituel avant le début de la maladie ;
- IMC $< 22 \text{ kg/m}^2$;
- sarcopénie confirmée* »

Ce qui est le cas de nos trois constats. Dans le cas de dénutrition sévère, la (HAS, 2021, p.10) ajoute que le taux d'albuminémie peut être inférieur ou égal à 30 grammes par litre, d'où l'intérêt de prendre en compte l'augmentation des besoins énergétiques et d'apporter les nutriments suffisants au besoin des personnes âgées. Ce qui nous renvoie au sous-concept de l'alimentation.

D'après (Ferry, 2010, p.124), l'alimentation est le fait « d'absorber tout ce qui peut servir à nourrir un être vivant, selon ses goûts, ses envies et le plaisir de manger une chose plutôt qu'une autre. » Elle joue un grand rôle dans le concept de dénutrition car sa première fonction est d'apporter les nutriments indispensables qui fournissent l'énergie à l'organisme (Laroque 2010). Cependant une alimentation insuffisante est souvent à l'origine du déficit de nutriment et la diminution de l'état énergétique et par conséquent une dénutrition. C'est pourquoi une alimentation ne doit pas être seulement saine et équilibrée mais aussi suffisante par rapport aux besoins de la personne âgée. D'où l'importance d'un apport convenable et d'une qualité nutritive. Ce qui nous ramène à un autre sous-concept qui est celui de la nutrition. La nutrition peut être définie comme « l'ensemble des processus d'absorption et d'utilisation des aliments, indispensables à l'organisme pour assurer son entretien et ses besoins en énergie. » (Ferry, 2010, p.124). Cependant, nous pensons qu'il serait important de ne pas confondre l'alimentation et la nutrition. Par ces définitions nous entendons que l'alimentation est le fait d'ingérer tout aliment sans prendre en compte la qualité nutritive alors que la nutrition est une manière que l'organisme utilise pour absorber des aliments ingérés lors de l'alimentation dans le but d'entretenir le corps. Cela montre que les apports nutritifs absorbés par l'organisme sont influencés par l'alimentation. Ce qui implique que le manque d'un élément indispensable (par exemple les protéines) peut occasionner une carence en protéine, ce qui fait penser à une dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée.

D'ailleurs (Rio *et al.*, 2018, n.p.) expliquent que « La dénutrition protéino-énergétique* apparaît chaque fois que l'alimentation n'est plus capable de couvrir les besoins de l'organisme, tant en quantité, c'est-à-dire en énergie (ou en calories), qu'en qualité, c'est-à-dire en protéines*. » Ainsi, cette définition nous fait penser qu'une diminution énergétique et nutritionnelle, qui font partie des caractéristiques de la dénutrition, sont causées par une alimentation insuffisante en qualité et/ou en quantité et/ou une augmentation de besoin en nutriment. En effet, l'alimentation insuffisante, qui n'apporte pas assez de nutriments par rapport aux besoins de l'organisme, est une cause de la dénutrition. D'après (Patry et Raynaud-Simon, 2010), les conséquences de la dénutrition sont majeures et particulièrement néfastes chez les personnes âgées. Ils atteignent ainsi l'idée de (Busnel et Ludwig, 2018, p.55) qui affirment que :

Chez la personne âgée, la dénutrition n'est pas sans conséquences (3). En effet, elle accroît la susceptibilité aux infections, retarde la cicatrisation et peut exercer des effets délétères sur les fonctions cardiaques et respiratoires (4). La dénutrition augmente également les risques d'ostéoporose, de maladies chroniques et de comorbidités (5). Elle est souvent considérée comme une composante importante de la fragilité de l'âge (6). Enfin, la dénutrition augmente le risque d'événements de santé indésirable tels que les chutes (7), la perte d'indépendance fonctionnelle, l'allongement des séjours hospitaliers (8), les institutionnalisations (8) et les décès (9).

(Ferry, 2010, p.126), dans le même ordre ajoute que :

Les conséquences de la dénutrition sont importantes puisqu'elle est à l'origine d'une diminution des défenses anti-infectieuses, d'une accélération de la perte de masse musculaire et osseuse, donc d'une augmentation du risque de chutes et de fractures, le tout concourant à une perte d'autonomie.

À travers les littératures décrites par ces auteurs, nous constatons que la dénutrition entraîne des conséquences qui peuvent s'avérer délétère pour la santé des personnes âgées. Dans le premier constat, nous avons relevé une perte de poids considérable chez Madame C., une perte de masse musculaire, une faiblesse musculaire, une fragilité physique, une chute, une dégradation de l'état de santé ainsi qu'un prolongement de la durée d'hospitalisation. Dans le deuxième constat chez Monsieur T., nous avons observé un amaigrissement, une dégradation de l'état de santé, un début d'escarre, ainsi qu'un décès. Monsieur T. avait des comorbidités associées à une dénutrition qui se sont installées, son pronostic vital était engagé et son décès a été anticipé.

Dans le troisième constat, nous avons remarqué une perte de poids chez Madame L., une aggravation de sa plaie d'escarre, une faiblesse musculaire ainsi qu'une infection urinaire qui est probablement liée à la diminution de ses défenses immunitaires suite à la dénutrition.

En résumé, nous avons remarqué que la dénutrition est très répandue chez les personnes âgées et représente un syndrome gériatrique majeur avec une étiologie multifactorielle et des conséquences néfastes sur leur santé ainsi que leur qualité de vie. C'est pourquoi dans l'étape suivante, nous allons aborder une approche préventive. Ce qui nous ramène au concept de prévention.

2.1.2 Prévention

Le concept de prévention renvoie à plusieurs définitions en fonction du domaine dans lequel celui-ci est attribué. Selon l'organisation mondiale de la santé (OMS,1948), cité dans (Vanmeerbeek, 2015, p.4) « la prévention est l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et les handicaps ». En (1999), l'OMS ajoute que la prévention de la maladie comprend des mesures qui visent non seulement à empêcher l'apparition de la maladie, telle que la lutte contre les facteurs de risque, mais également à en arrêter les progrès et à en réduire les conséquences. Dans le cadre de la prévention de la dénutrition chez les personnes âgées (Patry et Raynaud-Simon, 2010, p.169), pensent que c'est même une priorité. Du même avis (Gires, 2018), préconise que la prévention de la dénutrition est une nécessité. Elle progresse ensuite dans ses idées en faisant mention de la connaissance des spécificités physiologiques, mais surtout de l'identification et la gestion des situations à risque pouvant provoquer une dénutrition. Par-là, elle rejoint l'idée de L'OMS dans la lutte contre les facteurs de risques comme moyen de prévention. En (1948), l'OMS distingue trois stades de prévention : La prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Les caractéristiques du concept étant retrouvés dans les trois types de prévention.

La prévention primaire :

Elle vise à empêcher l'apparition d'une maladie, elle concerne des personnes saines et se situe en amont de l'apparition des maladies. Le but étant donc de diminuer l'incidence d'une maladie dans une population. Le public cible choisi dans le cadre de notre thématique est « la personne âgée ». Car d'après nos différents constats et études quantitatives, ce sont les sujets les plus touchés par ce phénomène de dénutrition. C'est pourquoi une prévention primaire chez ces personnes en bonne santé serait d'un apport bénéfique et réduirait l'incidence de la dénutrition au sein de cette même population.

Seulement pour que cela soit réalisable, il faut que les personnes âgées autonomes, indépendantes pour les activités de la vie quotidienne et qui s'alimentent très bien puissent bénéficier d'une éducation nutritionnelle en milieu hospitalier ou dans une MRS. Le but étant de leur encourager à maintenir leur comportement alimentaire de santé. Par exemple expliquer à un patient ou résident en bonne santé, les bienfaits d'une alimentation saine, suffisante, équilibrée et variée pour la santé et à contrario les méfaits d'une alimentation trop riche, trop sucré, trop salé, le jeûne et les repas sautés ou une alimentation déficiente. Ces éléments négatifs pouvant constituer des facteurs de risque de maladie et ou de dénutrition. Un autre exemple est le fait de leur expliquer l'importance d'un statut nutritionnel correcte pour le maintien d'un poids optimal, ainsi que le renforcement du système immunitaire afin d'éviter une certaine fragilité. Cette prévention primaire peut également s'appliquer chez une personne âgée dépendante qui s'alimente très bien. Néanmoins, il faut tout de même reconnaître que la dépendance en particulier pour l'alimentation en raison d'une pathologie ou d'un handicap reste un facteur de risque de la dénutrition d'après la (HAS, 2007). Ainsi, nous pensons qu'une personne dépendante est une personne qui a besoin d'une aide alimentaire. Cette aide qu'elle soit partielle ou totale ne peut être apportée que par autrui représenté par le personnel soignant ou la famille du patient ou du résident. Cependant, ce rôle d'aide alimentaire n'est pas toujours accompli avec efficience. L'exemple illustré est le cas de monsieur T., qui s'alimentait très peu ou refusait la prise alimentaire lorsqu'il constatait qu'une infirmière était pressée pour lui donner à manger. Cette attitude de « soignant trop pressé » a instauré un cadre défavorable qui a provoqué une baisse d'appétit et par conséquent la dénutrition de Monsieur T.

En tout état de cause, nous avons constaté que la plupart des patients gériatriques en raison des pathologies, présentent des facteurs de risques de dénutrition, ce qui nous renvoie à une prévention secondaire.

La prévention secondaire :

Selon l'OMS (1948), la prévention secondaire vise à diminuer la prévalence d'une maladie dans une population. Elle a pour objectif de stopper ou retarder l'évolution d'une maladie et ses effets par le dépistage précoce et un traitement approprié. Le dépistage précoce dont fait allusion l'OMS ici dans cette deuxième étape de la prévention consiste à dépister des patients à risque de dénutrition dès leur admission dans les institutions. Ce qui s'inscrit dans le cadre de notre rôle infirmier.

Ainsi, avant de procéder à un dépistage précoce, il est tout de même important de rappeler comme nous l'avons déjà abordé plus haut quelles sont les facteurs de risque de dénutrition, ces facteurs de risque faisant partie des prérequis de notre concept. Ainsi, la (HAS, 2007), a énuméré quelques situations à risque de dénutrition chez les personnes âgées. Nous nous limiterons à celles qui sont en lien avec nos constats décrits ci-dessus. Ces situations sont :

- Les situations psycho-socio-environnementales difficiles telles que le deuil, l'isolement social, l'hospitalisation, l'institutionnalisation.

Dans le même ordre d'idée (Gires, 2018) soutient que les pathologies et les problèmes psycho-sociaux font partie des facteurs déclenchant ou aggravant une dénutrition. Cela se vérifie dans le cas de Madame C. qui ne s'alimentait presque plus à cause du stress de l'hospitalisation et du décès de son époux l'ayant menée à une dénutrition. Dans cette situation, le facteur de risque était un problème psycho-social-environnemental qui a été identifié à temps. Car à la suite de cela, une thérapie médicamenteuse a été mise place (les anxiolytiques) dans le but de résoudre ce problème. Seulement, nous trouvons que ce n'était pas un moyen suffisant pour lutter contre ce facteur de risque. En complémentarité, une technique de la relation d'aide (présence, écoute active) aurait pu être instaurée dans les interventions.

- Les troubles bucco-dentaires : La cavité buccale de Madame L. était en mauvais état.

Elle avait aussi un problème de dysphagie reliée à la douleur qui a provoqué une inappétence et par conséquent une dénutrition. En nous rapportant aux guidelines du protocole hospitalier de l'hôpital Vivalia : Evidence Based Nursing et Evidence Based Medicine (EBN et EBM, 2018), le rôle infirmier dans la prévention de la dénutrition consiste aussi à une inspection quotidienne de la cavité buccale. Cette inspection doit considérer les lèvres, la langue si elle est sèche, pâteuse, propre, la dentition si les prothèses dentaires sont présentes et adaptées, les muqueuses buccales si elles sont humides, s'il y a présence d'ulcérations, d'aphtose, une mauvaise hygiène ou une gingivite. Lors de la déglutition, l'objectivation de fausses déglutitions est indispensable et fait partie du rôle infirmier. Au cours de nos stages en milieu hospitalier, nous avons constaté que lorsqu'un patient est à risque de fausses routes, l'infirmière objective et transmet l'information à la logopède qui, à son tour fait une évaluation complète et attribue un score au patient pour les solides et les liquides. C'est en fonction de ce score que s'effectue le dosage des épaississants. Nous avons été interpellées par cette attitude positive.

En revanche, en nous référant au cas de Madame L. en MRS, son problème de dysphagie relié à la douleur n'a pas été découvert à temps. Ce qui l'exposait à une peur de s'alimenter, des risques de fausses déglutitions, et par conséquent une perte de poids. D'après la guideline de l'hôpital Vivalia (EBN et EBM, 2018), les fausses routes sont un risque pour la santé du patient et constituent également un facteur de risque majeur de la dénutrition. Nous avons de même remarqué lors des stages que la plupart des patients qui présentaient des problèmes de fausses déglutitions étaient souvent aussi exposés à une hydratation insuffisante par peur de déglutir de travers. C'est pourquoi notre rôle infirmier dans la prévention de la dénutrition consiste aussi à une surveillance correcte de l'hydratation.

- Des traitements médicamenteux au long cours, en particulier au moyen des corticoïdes, et la polymédication. Toute affection aigue ou décompensation d'une pathologie chronique, en particulier (douleur, escarre), une constipation sévère et pathologie infectieuse.

D'après nos constats, toutes ces personnes âgées étaient sous médication. Selon le centre Belge d'information pharmacothérapeutique (CBIP, 2018), il y a des médicaments qui peuvent ralentir le transit à l'instar des opioïdes, d'autres qui peuvent provoquer des malabsorptions comme les inhibiteurs de la pompe à protons chez Madame C. et les corticoïdes qui peuvent donner une sensation de satiété. Monsieur T. en particulier était sous corticothérapie dans le but de diminuer la réaction inflammatoire liée à son infection à la covid 19. Il souffrait également de constipation, ce point sera détaillé après. Quant à Madame L., elle avait une escarre et souffrait de douleur qui l'empêchait de satisfaire son besoin de boire et manger. Le rôle infirmier ici consistait à identifier à temps, le facteur de risque qui était la douleur et d'agir par une évaluation complète, l'administration d'un antidouleur en collaboration ainsi qu'une meilleure transmission des informations, sans toutefois oublier une réévaluation de la douleur, la dysphagie et l'état nutritionnel.

- La dépendance pour les activités de la vie quotidienne et en particulier pour l'alimentation et ou la mobilité.

Monsieur T. était dépendant et avait besoin d'une aide totale pour l'alimentation et la mobilisation. Étant donné qu'il passait ses journées au lit, il se mobilisait peu, et souffrait de constipation. Comme nous l'avons dit dans le constat, il prenait les laxatifs pour satisfaire son besoin d'éliminer qui était perturbé.

Il faut reconnaître que la perturbation d'un besoin (par exemple le besoin de se mouvoir) peut entraîner la perturbation d'un autre besoin (par exemple le besoin d'éliminer) et par conséquent une affectation du besoin de boire et manger ainsi qu'une atteinte à l'intégrité de la peau. Tous ces problèmes étaient présents chez Monsieur T. À cela, s'est ajouté l'attitude non bienveillante des soignants reliée au stress de l'isolement infectieux. Cette situation a influencé négativement son besoin de boire et manger qui n'était pas satisfait. Le rôle infirmier dans la prévention de la dénutrition consiste aussi à prévenir la survenue d'une constipation par une hydratation suffisante, une alimentation riche en fibre ainsi qu'une mobilisation régulière du patient. Celle-ci étant également une méthode bénéfique pour protéger ses téguments. Outre ces moyens de prévention, la guideline de l'hôpital Vivalia (EBN et EBM, 2018) propose de favoriser un cadre propice pour la prise alimentaire. En référence à la situation de Monsieur T., l'instauration d'un cadre propice lors de la prise alimentaire concerne le respect du rythme du patient. D'après les plaintes de ce dernier, les infirmières étaient « trop pressées » et n'allaient pas à son rythme. Cette attitude négative des soignants, ajoutée à d'autres facteurs cités plus haut ont conduit le patient à une perte de motivation de s'alimenter et par la suite une baisse d'appétit. D'ailleurs, d'après la guideline (EBN et EBM, 2018), le cadre propice est un élément capital et considère quelques points tels que le calme c'est-à-dire que le moment du repas doit être un moment de « plaisir », incompatible dans un environnement tumultueux et anxiogène. Assurer une aide logistique et humaine en cas de besoin, informer le patient sur l'importance de ces moments privilégiés de la journée. Respecter le rythme du patient, détecter les aversions alimentaires et assurer un suivi vers le service de restauration, impliquer les proches autant que possible, penser à fractionner les repas et prendre si possible des repas en collectivité sont des moyens qui peuvent aider à lutter contre la dénutrition des personnes âgées.

En ce qui concerne la prise des repas en collectivité, nous pensons qu'elle peut être facilement applicable dans une MRS contrairement à un milieu hospitalier où les patients mangent dans les chambres parfois individuelles. Comme nous avons souvent constaté dans les MRS, la prise des repas en collectivité est un moment très important pour la plupart des résidents, car ils sont contents de partager ces moments agréables. Pour soutenir cet argument, nous nous baserons des situations vécues en stage. Nous avons effectué un stage dans une MRS au début de la pandémie de la covid 19. Pendant notre stage, il n'y avait pas encore de cas d'infection déclarée dans cette MRS, mais le protocole de l'institution avait tout de même décidé que les résidents ne devraient plus partager les repas ensemble.

Tous les résidents mangeaient en chambre et cette situation ne leurs convenait pas. À la suite de cette décision, une perte d'appétit et de poids avaient été considérablement remarquées chez certains résidents.

Selon les recommandations de bonne pratique de l'hôpital Vivala (EBN et EBM, 2018), Le dépistage précoce du risque de dénutrition est un excellent moyen de prévention et fait partie du protocole hospitalier fondé sur les données probantes et les recommandations du conseil fédéral pour la qualité de l'activité infirmière (CFQAI). L'objectif de ce protocole étant la prévention de la dénutrition survenant au sein des hôpitaux Vivalia en dépistant de façon précoce les patients à risque de dénutrition à l'aide d'une échelle valide de dépistage initial : Le (NRS, 2002) ; décrire une méthodologie validée scientifiquement pour évaluer et grader le statut nutritionnel des patients à risque de dénutrition ; promouvoir et optimiser la prise en charge globale des patients dénutris ; améliorer la prise en charge infirmière du patient dénutri ou à risque de dénutrition afin d'améliorer le pronostic du malade dénutri en diminuant les complications qui lui sont associées. D'après ces recommandations de bonne pratique (EBN et EBM, 2018), le dépistage précoce passe obligatoirement par une observation clinique (aspect cachectique du patient), le calcul de l'IMC, une anamnèse contributive (une perte de poids récente, une modification des habitudes alimentaires, une inappétence), une surveillance pondérale ainsi que par le relevé des ingesta.

En appui de cette observation clinique indispensable et élémentaire, il existe d'autres outils de prévention tels que les échelles. Parmi les différentes échelles, le (NRS, 2002) est l'échelle de dépistage du risque de dénutrition utilisée pour les unités de soins des hôpitaux Vivalia. Cette échelle a été retenue pour sa spécificité et sa simplicité d'utilisation, validée sur le plan scientifique par la société Belge de nutrition clinique (SBNC), la HAS et les autorités fédérales (SPF Santé publique).

En référence à la situation de Madame C., un dépistage précoce a été réalisé à l'admission à l'aide de cette échelle (NRS,2002) initiale. Voir annexe 1 : L'échelle de dépistage initial infirmier de Madame C. D'après l'interprétation de l'échelle, le dépistage initial infirmier de Madame C. est douteux car Madame C. présente un score d'un point et est à risque de dénutrition. Trois semaines plus tard, une réévaluation a été faite, voir annexe 2 : L'échelle de dépistage initial infirmier de Madame C. au cours de son hospitalisation. Le dépistage initial infirmier de Madame C. est positif car elle présente un score à quatre, ce qui implique une dénutrition sévère.

Selon le protocole hospitalier Vivalia (EBN et EBM, 2018), lorsque le dépistage précoce est douteux (c'est à dire, lorsque le patient présente un score à un) ou positif (c'est-à-dire, que le score est supérieur ou égal à trois), l'infirmière doit informer le médecin et déposer un document dans le casier de l'unité de soins réservé à l'équipe diététique qui à son tour avant toute intervention auprès du patient informera préalablement le médecin responsable du patient afin de garantir une prise en charge concertée de celui-ci.

- Pour rebondir sur les facteurs qui influencent négativement l'état nutritionnel des patients hospitalisés (Melchior, 2001) parle de l'absence de mention du poids et de la taille dans les dossiers des malades.

En nous basant sur le protocole hospitalier décrit ci-dessus, une mention récente du poids et de la taille dans les dossiers des patients sont recommandées et font partie du dépistage précoce dans les moyens de prévention. Seulement au regard de nos constats, nous remarquons que celles-ci n'apparaissent pas toujours dans les dossiers. L'exemple est celui de Monsieur T. dont le dernier poids mentionné dans son dossier datait de deux ans et était celui de la MRS. Comme nous l'avons relaté dans le constat, sa perte de poids n'a pas été objectivée à cause de son hémiplégie, il fallait une balance spéciale dont le service ne disposait pas et se trouvait en difficulté de l'emprunter parce qu'il était en isolement infectieux. Pour cette raison, le dépistage précoce à travers l'utilisation de l'échelle NRS n'a pas pu être réalisé correctement chez Monsieur T. puisque son IMC n'a pas pu être calculé. Au regard de cette situation, nous pensons que le calcul de l'IMC reste un élément indispensable dans la détection de la dénutrition. C'est pourquoi un défaut d'absence de poids et de la taille peuvent avoir un impact dans l'utilisation correcte de l'échelle NRS et par conséquent un mauvais suivi des patients à risque. Dans la situation de la résidente Madame L., le poids avait été mentionné et montrait que Madame L. avait perdu du poids, mais aucune action n'a été entreprise à la suite de cette perte du poids. Dans l'autre situation chez Madame C., la perte du poids avait été objectivée et le facteur de risque avait été identifié, mais il n'y a pas eu de prise en charge précoce.

- Parlant des facteurs qui influencent négativement l'état nutritionnel des patients hospitalisés (Melchior, 2001) fait également allusion au défaut d'analyse des ingesta et le délai entre l'installation d'une dénutrition et l'assistance nutritionnelle.

Concernant l'analyse des ingesta, comme nous l'avons expliquée dans les constats, le relevé des quantités des repas ingérés par les patients n'est pas toujours juste, car il arrive souvent aux personnes de cuisine de débarrasser les plateaux repas avant que ceux-ci soient notés. Melchior, en parlant du délai entre l'installation d'une dénutrition et l'assistance nutritionnelle veut sous-entendre le temps qui s'écoule avant qu'une intervention ne soit mise en place. D'après nos observations en stage, il est vrai qu'il y a un temps de réaction qui n'est pas souvent efficace. En nous référant au cas de Madame C., après le dépistage précoce qui était douteux, un dossier devrait être déposé dans le casier de la diététicienne d'après le protocole du service. La question que nous nous posons est celle de savoir si cela a été fait à temps ? Nous retenons qu'il y a eu un retard dans la prise en charge. Par la suite de ce retard, une dénutrition s'est progressivement installée, vu que Madame C. présentait déjà des facteurs de risque de dénutrition depuis son admission dans le service de gériatrie. Ainsi, en absence de cette prise en charge précoce, une alimentation parentérale a été instaurée plus tard. La mise en place d'une alimentation parentérale fait partie de la prévention secondaire d'après la guideline (EBN et EBM, 2018) et permet de retarder le processus de dénutrition et parvenir à un état réversible, surtout lorsque tous les autres moyens instaurés sont insuffisants ou ont échoués. En ce qui concerne la résidente de la MRS, Madame L., comme nous avons expliqué plus haut, la mauvaise cavité buccale et la douleur qui l'empêchaient de satisfaire son besoin de boire et manger ont été également prises en compte tardivement. Ce délai entre la déclaration du problème et le temps d'action ont conduit Madame L. dans un état de dénutrition. Après avoir agi sur cette douleur, l'état nutritionnel de Madame L. s'est amélioré et la situation a été réversible. Mais, cette situation aurait pu être irréversible en cas de comorbidité et l'aurait conduit à une hospitalisation et par la suite à un décès comme chez Monsieur T., d'où l'intérêt d'une bonne prévention et un meilleur suivi, ce qui reste un idéal à atteindre.

- (Melchior, 2001), ajoute qu'il y a un intérêt limité porté à la nutrition dans les études de médecine ou de soins infirmiers.

Dans le même ordre d'idée, nous pensons que le temps de réaction tardif peut être aussi associé aux limites des connaissances dont parle Melchior dans le domaine de la nutrition. D'ailleurs d'après un sondage en stage, la plupart des infirmiers pensent que la nutrition fait partie du domaine de la diététicienne et ne semblent pas s'y intéresser. Pourtant, nous sommes le premier maillon en contact avec les patients ou résidents et constituons le point de départ de plusieurs démarches inter-métiers (médecins, diététiciens, service de restauration).

D'où l'intérêt de combler les lacunes de connaissances pertinentes pour une prise en charge précoce. Ainsi, nous pensons qu'une prise en charge précoce permet de stopper le processus de dénutrition à temps afin de parvenir à un état réversible. Seulement, après être parvenu à un état réversible, il est important de faire une éducation à la nutrition aux patients ou résidents et à leurs proches afin d'éviter des récides. Ce qui nous renvoie à une prévention tertiaire.

La prévention tertiaire :

Selon l'OMS (1948), elle vise à diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou des récides dans une population, donc à réduire les modalités fonctionnelles consécutive à la maladie. Pour limiter les récides, nous pensons qu'il serait nécessaire de sensibiliser les patients ou résidents ainsi que leurs proches. Ce qui doit passer par l'instauration d'un programme d'éducation à l'alimentation chez toutes les personnes à risques de dénutrition ou dénutris. Ce programme d'éducation peut être supervisé par les infirmiers dans l'intérêt de les sensibiliser aux problèmes nutritionnels et éveiller la prise des consciences également chez les patients, résidents et les familles concernant la dénutrition. Comme nous l'avons dit dans les constats, Madame C. lors de son retour à domicile a bénéficié d'une éducation à la nutrition par l'infirmière. Nous avons été interpellées par cette attitude positive impliquant l'infirmière, Madame C. et sa fille pour un meilleur suivi du retour à domicile afin d'éviter une récive. Au niveau des institutions, nous pensons également que les programmes de formations continues peuvent permettre aux personnels infirmiers et aides-soignants, un accroissement des connaissances dans le domaine de la nutrition et par conséquent une meilleure détection pour une prise en charge précoce du patient. D'après (Patry et Raynaud-Simon, 2010), la dénutrition implique les coûts médicaux et hospitaliers (prolongement de la durée d'hospitalisation) et voire des décès. C'est pourquoi nous pensons que le bénéfice attendu du dépistage de la dénutrition dans cette dernière étape de la prévention serait de réduire le délai de sa prise en charge et par la même occasion, réduire l'incidence des complications et de ses coûts. Ce qui est une suite favorable du concept de prévention.

En substance, nous pensons que la prévention reste un excellent moyen pour combattre la dénutrition des personnes âgées. Seulement pour que cet idéal soit atteint, il faudrait que le patient soit lui-même impliqué dans cette démarche. C'est pourquoi une éducation nutritionnelle serait nécessaire, ce qui nous renvoie au concept d'éducation nutritionnelle du patient.

2.1.3 Education Nutritionnelle du patient

Selon Deccache et Lavendhomme (1989, p.45)

L'éducation du patient est un processus par étapes, intégré dans la démarche de soins, comprenant un ensemble d'activités organisées : de sensibilisation, d'information, d'apprentissage et d'aide psychologique et sociale, concernant la maladie, les traitements, les soins, l'organisation et les procédures hospitalières, les comportements de santé et ceux liés à la maladie destinée à aider le patient (et sa famille) à comprendre la maladie et les traitements, à collaborer aux soins, à prendre en charge son état de santé et à favoriser un retour aux activités normales.

Cette définition nous permet déjà d'identifier sept éléments représentés ici comme des caractéristiques du concept à savoir : (la sensibilisation, l'information, l'apprentissage, les comportements de santé et de maladie ainsi que l'aide psychologique et sociale). En considération de cette même définition, Deccache et Lavendhomme veulent nous faire comprendre que l'éducation du patient relève de la démarche des soins et met le patient au centre du processus. D'après ces auteurs, le patient doit lui-même être acteur de ses soins. C'est ainsi que Ivernois et Gagnayre (1995, p.5-7) rejoignent la même idée en faisant recours au concept d'auto-soin. D'après eux, le patient est capable d'être son propre médecin pour une période donnée. En référence au cas de Madame C., le fait de mettre en place une éducation à l'alimentation pour un meilleur suivi du retour à domicile a permis d'intégrer la patiente dans la gestion de ses soins alimentaires. Ainsi, Madame C. pourra elle-même devenir responsable de ses soins nutritionnels. Le fait de rendre la patiente responsable de ses soins lui permettra une certaine autonomie, une indépendance et donc un empowerment. C'est pourquoi d'après Doumont *et al.* (2002, p.1), de nombreux auteurs considèrent l'empowerment comme un enjeu certain dans toute démarche éducative du patient. Plusieurs auteurs ont défini l'empowerment, mais nous retiendrons la définition qu'en donnent (Israël *et al.*, s.d. cité dans Doumont *et al.* 2002, p.1). Ces auteurs définissent le concept d'empowerment individuel ou psychologique comme étant :

La capacité d'un individu à prendre des décisions et à exercer un contrôle sur sa vie personnelle. Comme le sentiment d'efficacité ou l'estime de soi, l'empowerment met l'accent sur le développement d'une représentation positive de soi-même (self concept) ou de ses compétences personnelles.

Cette définition nous fait penser au pouvoir de capacitation et de décision que peut avoir un patient sur la gestion de ses soins et de sa qualité de vie. Le fait qu'un patient puisse avoir un pouvoir de décision lui permettra une certaine valorisation et donc un renforcement de l'estime de soi, une certaine compliance et observance dans les soins. Ce qui rentre également dans le cadre des spécificités du concept d'éducation du patient. Seulement, pour que cela soit effectif, il faudrait que le patient puisse disposer des ressources suffisantes. C'est ainsi que (Ford *et al.*, s.d. cité dans Doumont *et al.*, 2002, p. 1), réfère l'empowerment au développement des ressources personnelles (sociales, psychologiques, intellectuelles et spirituelles) afin de donner à la personne les moyens de contrôler et de diriger sa propre vie. Les ressources personnelles dont sous entendent Ford *et al* constituent un facteur pouvant influencer positivement ou négativement l'empowerment du patient. Car si un patient ne dispose d'aucune ressource, il ne sera pas compliant dans la gestion de ses soins même si celui-en est le décideur. Cependant un patient qui dispose des ressources suffisantes (un environnement adéquat, les finances, une faculté intellectuelle ainsi qu'un soutien psychologique et social) sera motivé à participer aux soins.

En référence au cas de Madame C., la question que nous nous posons est celle de savoir comment celle-ci arrivera à gérer correctement ses soins nutritionnels à domicile afin d'éviter une dénutrition qui est considérée ici comme un antécédent du concept d'éducation au patient. Madame C. était autonome au domicile, cela dit auparavant, elle n'avait pas besoin d'une aide à domicile dans la réalisation de ses activités de la vie quotidienne. Après son hospitalisation due à l'altération de l'état général et la dénutrition, Madame C. s'est fragilisée et a besoin d'être soutenue dans une démarche éducative par la mise en place d'un réseau d'aide de soins à domicile qui prendra le relais et assurera la continuité des soins par une relation thérapeutique et le suivi du statut nutritionnel de la patiente. Seulement cette démarche nécessite également l'implication des proches du patient. Par exemple la fille de Madame C., en collaboration avec le réseau d'aide peut trouver un arrangement pour que Madame C. puisse bénéficier soit des repas sur roue ou soit solliciter une aide familiale qui pourra lui faire des courses et lui préparer ses repas en fonction de ses goûts. Ainsi, le résultat attendu de cette éducation serait d'éviter une récurrence qui induit des complications, des hospitalisations prolongées, des coûts à l'état et voire des décès.

2.2 Analyse d'un article probant

Dans le cadre de notre travail concernant le rôle infirmier dans la prévention de la dénutrition chez les personnes âgées, nous allons procéder à une recherche documentaire et analyser un article probant. Le but de cette démarche étant d'identifier, de collecter et de traiter des informations sur le domaine concerné, en s'appuyant sur des sources fiables afin d'étoffer notre thématique et approfondir ainsi nos connaissances.

Dès lors pour nos recherches engagées, nous avons été dans les bases de données de PubMed Advanced, après avoir déterminé les concepts constitutifs en français « rôle infirmier, prévention, dénutrition, personnes âgées » que nous avons traduit en anglais scientifique via un site de portail terminologique de santé Hetop pour obtenir les termes suivants : « nurse's role, preventive, malnutrition, aged » et en termes MeSH sur PubMed : « nurse's role[MeSH Terms] ,preventive medicine[MeSH Terms], malnutrition[MeSH Terms] aged[MeSH Terms] ». Nous avons ensuite utilisé les opérateurs booléens « AND » et « OR » pour interrelier nos concepts et avons obtenu l'équation de recherche suivante : (((nurse's role[MeSH Terms]) AND (preventive medicine[MeSH Terms])) OR (malnutrition[MeSH Terms])) AND (aged[MeSH Terms]). Pour cette équation nous n'avons abouti à aucun résultat. Nous avons alors omis le concept « rôle infirmier » et n'avons malheureusement pas trouvé d'article répondant à nos attentes. Ainsi, nous avons été obligées d'omettre encore le concept « prévention » et utiliser deux concepts dans notre recherche pour pouvoir obtenir des propositions d'articles en lien avec notre thématique. D'après notre nouvelle équation de recherche : (malnutrition [MeSH Terms]) OR (aged [MeSH Terms]), nous avons obtenu 3,470,326 résultats sans filtre. Cependant, pour avoir plus de pertinence, nous avons filtré notre recherche sur dix années, textes entiers avec une revue systématique et les résultats que nous avons obtenus s'élevaient à 14,097. Parmi les différents articles proposés, nous avons été interpellées par un article qui traite en majeure partie notre thématique : **Risk Factors For Malnutrition In Older Adults : A Systematic Review of the Literature Based on Longitudinal Data**. Les auteurs ayant œuvrés sur cet article sont : Nadia Cristina Favaro-Moreira, Stefanie Krausch-Hofmann, Christophe Matthys, Carine Verecken, Erika Vanhauwaert, Anja Declercq, Geertruida Elsie Bekkering, Blague Joke Duyck.

Il s'agit d'une équipe scientifique composée de chercheurs, d'endocrinologues et de médecins ayant une expérience en santé bucco-dentaire et en nutrition clinique.

Le contexte dans lequel l'étude a été réalisée nous met face à une revue systématique qui fait une analyse critique à travers d'autres littératures scientifiques sur les facteurs de risque de la malnutrition/dénutrition des personnes âgées afin d'envisager les stratégies de prévention par les professionnels de santé.

L'objectif de cette étude vise donc à faire un examen critique de la littérature scientifique disponible en mettant l'accent sur les études de conception longitudinales sur les facteurs de risque de malnutrition dans la population âgée. L'évaluation des preuves de ces facteurs de risque étant nécessaire pour faciliter le développement d'un instrument d'évaluation qui permettra aux professionnels de la santé d'identifier le risque de malnutrition des personnes âgées et de soutenir le développement des stratégies de prévention. Le public cible ici concerne les personnes âgées de 65 ans et plus. Au niveau de la méthode, c'est une revue systématique de type méta-analyse car les auteurs ont réalisé une synthèse d'autres études, en utilisant les lignes directrices PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), les lignes directrices de Cochrane pour planifier, mener et rapporter cette revue systématique. Ils ont été également dans les bases de données de MEDLINE et PubMed et ont obtenu des données quantitatives. Les critères d'inclusion concernaient les articles rédigés en anglais et publiés entre le 1^{er} janvier 2000 et le 30 mars 2015, et qui présentaient des données sur les facteurs de risque de malnutrition/dénutrition chez les personnes âgées de 65 ans et plus de toutes populations (logements communautaires, institutionnalisés, hospitalisés, ruraux ou urbains). Les résultats de ces études ont montré que parmi 2499 articles passés en revue, au total six études longitudinales répondaient à ces critères d'inclusion et ont été incluses dans l'examen systématique en lien avec notre thématique. Vu le nombre d'articles identifiés, nous pensons que les résultats ne sont pas assez significatifs. En plus dans les critères d'inclusion de ces études, les auteurs n'ont pas seulement fait mention de la population âgée hospitalisée et ou institutionnalisée, mais aussi des populations âgées urbaines et rurales. Seulement nous pensons que les populations âgées urbaines et rurales (non institutionnalisées) ne présentent pas forcément les mêmes facteurs de risques de dénutrition qu'en milieux hospitaliers ou MRS, ce qui peut légèrement influencer sur la qualité des résultats concernant notre thématique. Comme nous l'avons déjà évoqué à travers certains auteurs, le pourcentage de la dénutrition peut différer d'un environnement à l'autre en fonction des facteurs de risque et est plus élevé en milieux hospitaliers qu'en MRS. D'après les auteurs de cet article Favaro-Moreira *et al.* (2016), ce pourcentage est encore plus bas c'est-à-dire de 1 à 15% chez les personnes âgées non institutionnalisées.

Cela signifie que les personnes âgées à domicile présentent moins de facteurs de risque, étant donné qu'elles sont chez elles avec tous leurs repères, et préfèrent parfois le soutien des aidants naturels, ce qui les expose moins aux risques de dénutrition contrairement quand elles sont institutionnalisées. Plusieurs études ont démontré que l'institutionnalisation apparaît comme un grand facteur de risque de la dénutrition (Favaro-Moreira *et al.*, 2016). Nous pensons ainsi aux résidents qui se sont retrouvés en MRS contre leur volonté. L'entrée en MRS représente une sorte de perte et de fin et peut exposer certains à un syndrome de glissement. D'après les études réalisées par (Favaro-Moreira *et al.*, 2016), la prévalence de la dénutrition dans les MRS s'élevait de « 25 à 60% » et en milieux hospitaliers de « 35 à 65% » et ce taux de prévalence est similaire aux études réalisées en 2010 par Patry et Raynaud-Simon. En milieux hospitaliers, ce taux reste encore élevé en raison des facteurs de risques que nous avons relevés plus haut et dans nos constats à travers certains auteurs : (stress de l'hospitalisation, manque de temps du personnel, le jeûne ou les repas sautés à cause des examens complémentaires).

L'une des limites de l'étude par rapport à notre travail a été le fait qu'ils ont pris en compte des études qui ont été réalisées non seulement en Europe, mais aussi en Amérique et en Afrique, ce qui pouvait exercer une influence sur les facteurs de risque ainsi que la qualité des résultats, car les conditions du vieillissement de la population peuvent varier d'une culture à l'autre, d'un continent à l'autre et même d'un pays à l'autre. Par exemple en Afrique, il n'existe pas de maisons de repos et de soins, et les hôpitaux sont coûteux, ce qui fait que la plupart des personnes âgées vivent au domicile et bénéficient de l'aide des aidants naturels qui disposent suffisamment du temps, contrairement à la société occidentale industrialisée où le temps reste un facteur déterminant.

En revanche, cette étude a des atouts. Étant donné que c'est une étude de synthèse (une revue systématique), cela enchère beaucoup de preuve au niveau scientifique et se trouve au sommet de la pyramide. L'étude a été réalisée en 2016, ce qui signifie qu'elle est encore d'actualité. La substance extraite de l'examen systématique de cette étude correspond à l'étiologie multifactorielle que nous avons abordée dans la thématique de la dénutrition des personnes âgées, et la prise en compte de ces facteurs de risque comme excellent moyen de prévention sont ceux que nous avons également retrouvés dans les littératures utilisées et le protocole hospitalier de l'hôpital Vivalia (EBN et EBM, 2018). Ce qui veut dire que les recommandations faites par cette étude pour prévenir la dénutrition de la personne âgée peuvent tout de même être transposables dans notre société en Belgique.

Outre, parmi les auteurs ayant rédigés l'article, la plupart venaient de l'université de Louvain en Belgique et étaient dans le domaine de la nutrition clinique et science de la santé buccale.

Au regard de toutes ces littératures utilisées concernant la dénutrition des personnes âgées, nous allons nous diriger vers les équipes de terrains qui sont en premier ligne face à cette problématique. Ce qui nous renvoie à une enquête exploratoire.

2.3 Enquête exploratoire

Après une analyse conceptuelle des principaux concepts que nous avons développés et l'analyse de l'article probant, nous nous sommes rendues compte que la dénutrition est un problème majeur pour nos aînés. Dans les différentes littératures consultées, nous avons remarqué que la dénutrition avait plusieurs causalités. Plus précisément dans nos constats, nous avons mis en évidence la banalisation de la dénutrition des personnes âgées liée probablement aux limites de connaissance, l'attitude de soignant pressé et l'absence d'utilisation ou la mauvaise utilisation des outils d'évaluation et le retard dans les interventions des soins de la part des infirmiers. Ainsi, une enquête exploratoire serait indispensable afin de récolter des avis des équipes de terrain. Le but étant de mener des entretiens sur le terrain, comparer et faire une corrélation entre l'aspect théorique et la réalité pratique.

Pour les besoins de notre enquête, Vanette s'est rendue à l'hôpital dans un service de gériatrie et Jeannette s'est rendue dans une maison de repos et de soins où nous avons rencontré et interviewé les infirmières en chef. Nous avons mené un entretien semi-dirigé en présentiel avec l'infirmière en chef responsable du service de gériatrie et l'infirmière en chef dans une MRS. L'objectif général de ces enquêtes qualitatives étant d'obtenir aussi des éléments de réponses face à nos questionnements sur le rôle infirmier dans la prévention de la dénutrition des personnes âgées, ce qui nous a permis de mieux étoffer notre sujet.

Concernant l'enquête dans le service de gériatrie, Vanette s'est orientée vers l'infirmière en chef parce que d'après le protocole hospitalier de Vivalia (EBN et EBM, 2018), faire de l'alimentation des patients un projet de qualité de l'unité de soins relève du rôle de l'infirmière en chef capital. En plus l'infirmière en chef au regard de ses responsabilités est la personne la plus informée, qui a assisté à des réunions multidisciplinaires concernant la thématique de la dénutrition, la seule personne disponible et capable de répondre à toutes nos interrogations.

À propos de l'enquête en MRS, Jeannette s'est dirigée vers l'infirmière en chef parce que c'est elle qui participe également aux réunions multidisciplinaires concernant la dénutrition des résidents et étant dans la capacité d'apporter des réponses à nos questions. Ainsi, les enquêtes se sont déroulées dans une pièce isolée et ont duré au moins une heure. Pour le service de gériatrie, il n'y a pas eu d'enregistrement possible mais les informations ont été relevées manuscritement. En MRS, les informations ont été enregistrées et retranscrites.

Nous avons formulé des questions ouvertes dont la première concernait les causes de la dénutrition des personnes âgées dans les hôpitaux et MRS, la question de relance visait le taux de prévalence de dénutrition élevé chez les personnes âgées hospitalisées et en MRS. L'objectif étant d'identifier à temps les facteurs de risque et prévenir ainsi la dénutrition. En réponse à ces questionnements, nous avons relevé de la part de l'infirmière en chef du service de gériatrie quelques facteurs à savoir l'âge avancé et les polypathologies qui contraignent parfois les patients gériatriques à rester à jeun pour certains examens complémentaires. D'après cette dernière, la plupart des patients gériatriques sont des personnes âgées malades et fragilisées qui refusent le plus souvent de s'alimenter. Certains patients âgés sont désorientés lorsqu'ils se retrouvent à l'hôpital dit-elle, et le stress de l'hospitalisation provoque chez ces patients une inappétence et en conséquence une dénutrition. Celle-ci ajoute que les patients gériatriques sont reconnus pour « arracher les cathéters et les sondes nasogastriques », malgré la stratégie nutritionnelle envisagée, ces désagréments peuvent influencer négativement le suivi nutritionnel du patient âgé dénutri. L'autre facteur énuméré est le manque du personnel soignant, car à cause de la pandémie de la covid 19, il y a eu plus d'absentéismes pour les raisons de maladie et moins de personnels soignants pour la surveillance des repas et l'aide à la prise alimentaire. Pour ce qui est de la MRS, l'infirmière en chef a fait mention d'une sous-alimentation ou une mauvaise alimentation liée à des effets secondaires de certains médicaments et des changements d'habitudes des résidents. En ce qui concerne la prévalence élevée dans des MRS, elle a soulevé le problème du placement des personnes âgées en MRS contre leur volonté par les familles. Des changements alimentaires habituels surtout pour les résidents nouvellement admis dans l'institution, les polypathologies et les polymédications liées à l'âge et le manque de temps du personnel pour s'occuper des résidents qui ont besoin de plus de temps pour s'alimenter. Ainsi, par cette dernière phrase, elle rejoint l'idée de l'infirmière en chef du service de gériatrie.

La deuxième question concernait les moyens mis en œuvre pour prévenir la dénutrition de la personne âgée, la question de relance faisait référence aux outils disponibles pour détecter et prévenir la dénutrition.

Le but étant de détecter de manière précoce les personnes à risque et d'agir efficacement. Pour le service de gériatrie, les réponses obtenues de la part de l'infirmière en chef ont été notamment l'application d'un protocole hospitalier de dénutrition (EBN et EBM, 2018) qui oblige de détecter tous les patients gériatriques dès leur admission dans le service par une surveillance régulière du poids, le calcul de l'IMC, l'utilisation de l'échelle (NRS, 2002). Elle déclare cependant que tous les outils ne sont pas disponibles car lorsqu'il s'agit d'un patient hémiparétique ou grabataire, le service se doit d'emprunter le matériel. Elle a aussi fait mention du relevé des quantités des repas consommés et l'usage des suppléments nutritifs oraux (le Fortimel ®) pour des patients qui ne s'alimentent pas assez comme l'un des moyens les plus utilisés en gériatrie pour prévenir la dénutrition. En ce qui concerne l'infirmière en chef de la MRS, dans le même sens, elle a également souligné le contrôle du poids qui se fait mensuellement et régulièrement en cas de doute. Cependant au niveau des outils, elle a déclaré qu'il n'y avait pas d'outil de détection proprement dit. Elle a ajouté que la détection d'une personne dénutrie ou à risque est faite « au cas par cas et de bouche à oreille entre les soignants ».

La troisième question que nous avons abordée parlait de l'intérêt des infirmiers à la nutrition, la question de relance se rapportait à l'existence d'un infirmier référent en nutrition au sein de l'équipe. L'objectif de cette question étant d'encourager les infirmiers à s'intéresser à la nutrition afin de développer une stratégie de prise en charge précoce concernant la problématique sur la dénutrition. Face à cette question, selon l'avis de l'infirmière en chef du service de gériatrie, la plupart des infirmières pensent que la nutrition fait partie du domaine de la diététicienne et ne s'y intéressent pas. D'ailleurs il n'existe pas d'infirmier référent en nutrition mais en tant qu'infirmière en chef, c'est elle qui a la responsabilité de véhiculer souvent les séances d'informations pour sensibiliser son personnel et au regard de ses multiples responsabilités, elle trouve que ça serait intéressant d'avoir un infirmier référent en nutrition. Par rapport à l'avis de l'infirmière en chef de la MRS, dans le même sens, elle affirme que la nutrition n'est pas un domaine auquel les infirmiers s'intéressent car selon ces derniers, ce domaine est celui du nutritionniste et il n'existe pas d'infirmier référent en matière de nutrition. Celle-ci ajoute que d'ailleurs ça serait une bonne idée d'avoir un infirmier référent en nutrition. Nous avons ainsi clôturé l'entretien par une quatrième question concernant le rôle infirmier dans la prévention de la dénutrition, la question de relance faisait allusion aux formations continues. Le but ici étant de savoir si les infirmiers mettent à jour leur connaissance par rapport à des nouvelles recommandations dans la prise en charge de la dénutrition afin de mieux prendre en charge les personnes à risque.

En réponse à cette dernière question, l'infirmière en chef du service de gériatrie a évoqué que les infirmiers ont un rôle à jouer dans la détection du patient dénutri ou à risque grâce à l'application des outils de prévention prévus dans le protocole hospitalier. Elle pense même que le rôle de l'infirmier est capital en ce sens que c'est lui qui informe le médecin et ou le diététicien étant donné que c'est lui qui est auprès du patient. Mais précise que la prise en charge du patient dénutri ou à risque reste quand même multidisciplinaire. Parlant de la mise à jour des connaissances, elle dit avoir assistée à des réunions pluridisciplinaires avant la crise sanitaire et affirme que les séances d'informations à la suite de ces réunions étaient véhiculées aux infirmiers et aides-soignants. Quant à l'infirmière en chef de la MRS, du même avis, elle affirme que la nutrition fait partie du rôle infirmier ; mais pour elle, normalement, c'est principalement le rôle d'une nutritionniste. Elle a ajouté que tout de même, c'est un travail qui se fait en équipe multidisciplinaire. En plus, tout personnel a sa part de responsabilité dans la prévention de la dénutrition. L'infirmière ne peut pas jouer ce rôle toute seule. Cependant, c'est l'infirmière qui est au chevet des résidents c'est-à-dire qu'elle détectera plus facilement les signes de dénutrition avant les autres. À propos de la mise à jour des connaissances, elle a fait mention d'une participation à des réunions multidisciplinaires avant la crise sanitaire et aux séances d'informations après cette participation.

Après avoir analysé les données de ces entretiens, il en ressort qu'il existe des similitudes et des différences d'opinions entre les littératures et la réalité pratique. Au niveau des similitudes, nous avons remarqué que les apports insuffisants au regard des besoins de la personne âgée sont la principale cause de la dénutrition. Nous avons aussi relevé entre autres les polypathologies et les polymédications, la dépendance dans les soins survenant avec l'âge avancé, les changements du milieu et le stress de l'hospitalisation qui majorent la prévalence du patient âgé dénutri, rejoignant ainsi l'idée de la (HAS,2007), Patry et Raynaud-Simon (2010), Melchior (2001) et de Favaro-Moreira *et al.* (2016). Ce qui permet de porter un regard scientifique. Nous avons également constaté que la dénutrition sévit plus en milieu hospitalier et plus particulièrement dans un service de gériatrie parce que la plupart des personnes hospitalisées sont des patients âgés qui arrivent à l'hôpital dans un contexte de comorbidités ou de pathologies aiguës ou chroniques, contrairement à un hôpital de jour où ce taux de dénutrition reste moins significatif du fait que les patients qui sont admis dans ces services sont des personnes encore relativement autonomes. Il en est de même pour les résidents dans les MRS, nous avons constaté que le pourcentage de dénutrition dans ces milieux reste encore inférieur à celui d'un service de gériatrie parce qu'en MRS, parmi les résidents, certains sont encore physiquement plus en forme.

En plus, les résidents bénéficient d'une ambiance plus conviviale, ils prennent des repas en collectivité. Cependant le pourcentage de dénutrition est majoré en MRS par rapport à celui du domicile. Comme nous l'avions déjà mentionné plus haut, ceci en raison du fait qu'au domicile les personnes âgées sont chez elles et ont tous leurs repères, parfois entourées de leurs familles, ce qui leur procure un sentiment de sécurité et de bien-être. En revanche, lorsque ces personnes âgées sont institutionnalisées surtout contre leur gré, il y a un risque de dépression, d'anorexie mentale et même un syndrome de glissement en plus de certains facteurs de risque déjà précités. Ce qui justifie l'accroissement du taux de dénutrition en MRS. Lors des entrevues, nous avons également relevé qu'il y avait un intérêt limité des soignants porté dans le domaine de la nutrition, déjà évoqué ci-dessus par Melchior (2010). D'après les entrevues, les soignants ne considèrent pas l'alimentation comme un soin. Selon ceux-ci, c'est le domaine de la diététicienne. D'ailleurs, il n'existe pas au sein du service de gériatrie et en MRS un infirmier ayant une expérience en nutrition. Néanmoins des séances d'informations sont véhiculées pour sensibiliser davantage le personnel soignant ainsi que les formations continues qui sont organisées par trimestre à l'hôpital et annuellement en MRS. En ce qui concerne l'infirmier référent en nutrition, les deux infirmières en chef ont précisé que bien qu'il existe une équipe diététique, ça serait intéressant d'avoir en plus un infirmier ayant une expérience en nutrition auquel il faudrait consulter lors d'un problème de dénutrition. Sa présence peut être très utile, dans l'organisation des formations internes et les séances d'informations surtout avec la pandémie à la covid 19 donc les formations continues n'ont pas pu avoir lieu depuis un certain moment.

Au niveau des divergences d'opinions entre les littératures et les entrevues, nous avons notamment relevé de la part des infirmières en chef des éléments du terrain souvent ignorés dans les littératures tels que l'effectif limité du personnel qui induit le manque de temps surtout dans la période de pandémie de la covid 19, la lourdeur des soins et l'épuisement des soignants, les conditions d'isolements difficiles reliées à la pandémie de la covid 19, le travail multidisciplinaire en ce sens que les stratégies de prise en charge nutritionnelle ne relèvent pas du rôle autonome de l'infirmier. Au niveau des outils de détection, l'échelle utilisée par excellence dans le service de gériatrie est le (NRS,2002) contrairement au MNA recommandé dans les littératures. En comparaison de ce qui a été dit par les infirmières en chef, nous avons relevé une différence au niveau de la prévention du patient dénutri. En MRS, la détection se fait « au cas par cas et de bouche à oreille », contrairement à l'hôpital où la détection se fait systématiquement dès l'admission du patient.

De même, excepté une surveillance pondérale mensuelle, il n'y a pas d'outils de prévention proprement dit en MRS. Un autre point qui n'avait pas été mentionné dans les littératures et qui a été abordé sur le terrain dans le service de gériatrie est le protocole de mesure talon-genou grâce à un mètre ruban à deux faces en fonction du sexe (l'équation de chumléa). L'équation de chumléa est un outil de prévention pour mesurer la taille chez les personnes âgées n'étant plus capable de se tenir debout ou ayant un tassement vertébral et ou une scoliose (EBN et EBM, 2018). Ce que nous avons trouvé très intéressant. Voir annexe 3 : l'équation de chumléa.

Cette enquête exploratoire n'est pas pour autant sans limite, l'une des limites de l'enquête a été le fait que nous nous sommes juste limitées qu'à l'avis d'une seule personne dans le service de gériatrie et en MRS, ce qui est peu représentatif. L'avis de l'infirmière en chef est un avis subjectif qui permet de porter un regard plus personnalisé. Les difficultés rencontrées lors de l'enquête à l'hôpital ont été le fait que nous avons été interrompues régulièrement par les coups de fils et d'autres personnels.

En somme, l'enquête exploratoire nous a permis de dégager des pistes de réflexion concernant la problématique sur la dénutrition de la personne âgée et nous a amenées au questionnement professionnel.

3 Synthèse, questionnement professionnel et pistes de réflexion

À la suite de nos constats et interpellation commune, nous avons un questionnement de départ à savoir **Quel est le rôle infirmier dans la prévention de la dénutrition des personnes âgées ?** À la lumière de notre analyse conceptuelle, de l'analyse de l'article probant en lien avec notre questionnement et à l'enquête exploratoire, nous avons remarqué que le manque d'intérêt des infirmiers en ce qui concerne la dénutrition des personnes âgées les empêche d'accomplir correctement leur rôle infirmier dans la prévention de ce fléau. Cependant, comme le pensent Volkert *et al.* (2019) et bien d'autres auteurs cités ci-dessus dans nos littératures, la dénutrition du sujet âgé reste un phénomène assez répandu dans les hôpitaux ainsi que les maisons de repos et de soins et représente un syndrome gériatrique avec une étiologie multifactorielle et des conséquences graves. Ce qui mérite de l'attention de la part des professionnels de la santé et nous amène ainsi à un questionnement professionnel à savoir :

Dans le cadre de la prévention de la dénutrition du sujet âgé, comment les infirmiers peuvent favoriser une démarche de qualité de soins ?

Nous avons fait mention dans la prévention secondaire de l'existence d'un protocole hospitalier Vivalia (EBN et EBM, 2018) accessible à tous et qui traite en résumé la détection et la prise en charge multidisciplinaire de la dénutrition de la personne âgée. Grâce à ce protocole, l'évaluation du risque nutritionnel des patients se fait systématiquement dès leur admission dans le service de gériatrie, ce qui est un élément positif. D'après ce même protocole, il existe des outils de détection de dénutrition ainsi qu'un comité de pilotage de liaison alimentation et nutrition (CLAN) et une équipe nutritionnelle composée d'un diététicien, d'un infirmier, d'un médecin, d'un pharmacien et du responsable de cuisine. Cette équipe se réunit au moins une fois tous les trimestres avec le CLAN pour coordonner et assurer un pilotage transversal d'une politique nutritionnelle dans l'institution. Ce qui nous dirige vers une démarche de qualité. Cependant, en référence à l'entrevue tenue avec les infirmières en chef, nous avons fait mention des facteurs organisationnels comme un obstacle à la qualité des soins par le manque de personnel soignant. Ce manque est dû non seulement à la pénurie des infirmiers et aides-soignants mais aussi aux absences pour maladie, ce qui implique encore toute une réorganisation dans les tâches et induit la lourdeur du travail. Le manque du temps ainsi que l'épuisement du personnel par suite d'un effectif restreint ont un impact sur la qualité des soins.

Un autre élément est la gestion des imprévus quand il y a des changements dans les plans de soins, des entrées ou des remontées du bloc opératoire en milieux hospitaliers qui nécessitent plus de temps et de surveillance et en conséquence ; un déséquilibre dans le suivi des autres activités comme l'aide à la prise des repas. Bien qu'il s'agisse d'un acte pouvant être délégué, il arrive souvent qu'une seule aide-soignante soit incapable d'apporter de l'aide nécessaire dans un service de gériatrie ou MRS où beaucoup de patients sont dépendants, ce qui contribue à des apports nutritionnels insuffisants chez les patients, des suivis inefficaces ainsi que les retards dans les interventions. À cela s'ajoute le problème d'indisponibilité du matériel dans les outils de prévention en milieux hospitaliers et plus particulièrement en MRS, le problème de l'absence d'outils de prévention, de l'absence d'un protocole ainsi que le manque de détection systématique. Un autre élément en milieu hospitalier est le manque de révision du protocole de dénutrition depuis 2018 ainsi que les formations continues qui ne se sont plus déroulées depuis deux années en raison de la pandémie de la covid 19 et les isolements infectieux.

Au regard de tous ces éléments évoqués ayant un impact sur la qualité des soins. Nous pensons qu'il serait intéressant d'envisager quelques pistes de réflexion. Parlant de la MRS, nous pensons que la mise en place et l'application correcte d'un protocole de dénutrition ainsi que les outils de détection et de prévention systématique peuvent être recommandés. Nous restons optimistes que cela permettrait la conformité des soins et faciliterait des suivis efficaces des personnes âgées dénutries et /ou à risque de dénutrition. Dans le même sens, nous pensons également qu'une application du protocole de dénutrition avec efficience ainsi qu'une révision de ce protocole et la reprise des formations continues en milieu hospitalier permettraient de réduire le taux de prévalence dans ce milieu.

En faisant référence aux échanges effectués lors de nos entrevues avec les infirmières en chef, nous avons souligné le manque de personne de référence en nutrition. Nous pensons autant que la présence d'un infirmier référent en nutrition peut être vivement conseillé dans les services gériatriques et dans les MRS. D'après les hôpitaux (Vivalia, s.d.) « Le référent est une personne ressource compétente dans un domaine particulier des soins infirmiers par son savoir, son savoir-faire et son savoir-être ». Ajoute que : « les référents font partie de groupes de travail permanents afin de partager leurs expériences et mettre en place des projets destinés à l'amélioration de la qualité des soins ». L'objectif étant d'améliorer les connaissances de ses collègues en leur partageant son savoir en matière de nutrition et par la même occasion améliorer le rôle infirmier dans la prévention de la dénutrition.

Dans le même ordre d'idée, nous pensons ainsi que la mise en place d'un programme d'éducation nutritionnelle dans les hôpitaux, MRS et domicile impliquant le patient lui-même, les proches aidants ainsi que tous les professionnels de santé concernés par la nutrition ou s'occupant des personnes âgées peut être un avantage dans la prévention de la dénutrition du sujet âgé. Cette éducation servira à informer, sensibiliser, apprendre et surveiller les causes, les facteurs de risque ainsi que les conséquences de la dénutrition.

Conclusion personnelle

La question qui a mobilisé notre réflexion depuis le début de ce travail était le rôle infirmier dans la prévention de la dénutrition des patients âgés hospitalisés et ou institutionnalisés. Étant donné le taux de prévalence de dénutrition élevé dans ces milieux ; il était question pour nous d'aborder cette thématique afin de pouvoir sensibiliser davantage le personnel soignant à la prise de conscience de la malnutrition ou dénutrition des personnes âgées qui reste encore un sujet peu intéressant pour eux. Tout au long de notre travail sur la prévention de la dénutrition des personnes âgées qui reste encore pour nous un idéal à atteindre, nous avons relevé des étiologies multifactorielles auxquelles les infirmiers doivent être attentifs afin de développer une stratégie de prise en charge précoce pour réduire les conséquences. Malgré tous les moyens mis en place pour détecter et prévenir la dénutrition chez nos aînés, nous avons remarqué que le pourcentage des patients dénutris reste encore élevé dans nos hôpitaux et en MRS en Belgique d'après les littératures et entrevues. C'est pourquoi un dépistage précoce même s'il est négatif ne doit cependant pas soustraire nos infirmiers à une vigilance quotidienne de l'état nutritionnel des patients.

En ce qui me concerne MEGUEU VANETTE, ce travail de fin d'étude a été très enrichissant en ce sens que j'ai été consultée les littératures scientifiques pour étoffer notre thématique, ce qui m'a permis en retour un accroissement des connaissances. Grâce à ce travail, j'ai appris à travailler en binôme, ce qui m'a aussi aidé à travailler le côté leadership de notre future profession. Le travail en binôme nécessite que les partenaires de travail soient sur la même longueur d'onde pour éviter les frustrations. Au regard de cette problématique sur la dénutrition des personnes âgées qui a suscité mon attention depuis mon premier stage en gériatrie, en tant que future infirmière, je m'engage à être bienveillante vis-à-vis des patients et particulièrement envers ces personnes âgées qui méritent du respect et de l'attention de la part des professionnels de santé. De même, de cette expérience, j'ai essayé de faire les liens entre les cours théoriques et les pratiques des professionnels en stage, ce qui m'a également permis de me remettre en question. J'ai également compris qu'une meilleure pratique n'est pas seulement celle qui reproduit intégralement de la théorie telle quelle mais aussi celle qui sait s'adapter en fonction de chaque situation. La finalité étant le bien être du patient singulier.

Pour ma part, UMUGWANEZA UWASE Jeannette, tout d'abord ce travail m'a permis de m'améliorer dans la recherche ainsi que l'analyse des articles probants et non probants. Cela m'a aidé à développer mon sens critique des articles tout au long de notre recherche. Ce travail m'a permis également de développer ma capacité de travailler en binôme, car cela n'est pas toujours évident, en fonction des idées parfois divergentes et surtout des emplois de temps différents. Au fur et à mesure que j'avancais dans le travail, j'ai pu constater les conséquences néfastes de la dénutrition envers les personnes âgées. Je me suis rendue compte de l'importance du rôle infirmier dans ce domaine. Etant donné que c'est l'infirmier qui est au chevet du bénéficiaire de soins, son rôle est très important que ce soit dans la prévention, dans la détection, ainsi que dans la prise en charge de la dénutrition. En effet, quand je serai infirmière, je mettrai en pratique les conseils ainsi que les recommandations que j'ai pu découvrir durant mon travail, entre autres, la mise en place et l'utilisation correcte des outils de détection de la dénutrition, bien sûr si cela n'aurait pas déjà été mis en place. Je partagerai également les connaissances que j'ai découvertes et acquises avec mes collègues afin de mettre en avant notre rôle infirmier par rapport à la dénutrition.

Liste des Références

- Arrêté royale du 22 août 2002 relative aux droits du patient. (2002). *Moniteur belge*, 26 septembre, p.43719.
- Brennstuhl, M. (2018). Déficits généraux en nutriments. Dans M. Brennstuhl (dir.). *Alimentation santé: De l'intestin au régime méditerranéen, toute l'alimentation santé expliquée* (pp. 57-69). Dunod.
- Busnel, C. et Ludwig, C. (2018). Dépister la dénutrition chez la personne âgée bénéficiant de soins à domicile : une évaluation de la précision diagnostique des indicateurs issus du Resident Assessment Instrument - Home Care adapté pour la Suisse. *Recherche en soins infirmiers*, 132, 54-63. <https://doi.org/10.3917/rsi.132.0054>
- Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique. (2018). Opioides, inhibiteurs de la pompe à protons, corticoïdes. Dans *le Répertoire Commenté des Médicaments*.
- Conseil d'Orientation des Retraite. (2019, 21 février). *Panorama international des âges effectifs de départ à la retraite* (Document n° 11). <https://www.cor-retraites.fr/sites/default/files/2019-06/doc-4446.pdf>
- Dallaire, C., Lambert, J. et Farshbaf Kamel, F. (2021). La proposition de structuration du savoir infirmier selon Fawcett : filiation et limites. *Recherche en soins infirmiers*, 144, 34-43. Récupéré de <https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2021-1-page-34.htm>
- Deccache, A. et Lavendhomme, E. (dirs.). (1989). *Information et éducation du patient. Des fondements aux méthodes*. De Boeck Université.
- Defloor, T., Herremans, A., Grypdonck, M. et al. (2004). *Echelle de Braden* (Mise à jour des recommandations Belges pour la prévention des escarres, pp.1-10). <https://best.ugent.be/BEST3 FR/download/decubitus>.
- Doumont, D., Aujoulat, I. et Deccache, A. (2002). L'empowerment, un enjeu important en éducation du patient. *Education du patient et Enjeu de Santé*, 21 (3), 1-5. <http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/reso/documents/dos18.pdf>

- Favaro-Moreira, N., Krausch-Hofmann, S., Matthys, C., Verreken, C., Vanhauwaert, E., Declercq, A., Bekkering, G. et Duyck, J. (2016). Risk Factors for Malnutrition in Older Adults : A Systematic Review of the Literature Based on Longitudinal Data [Facteurs de risque de malnutrition chez les personnes âgées : une revue systématique de la littérature basée sur des données longitudinales]. *Advances in nutrition*, 7 (3), 507-522. <https://doi:10.3945/an.115.011254>
- Ferry, M. (2010). Nutrition, vieillissement et santé. *Gérontologie et société*, 33(134), 123-132. <https://doi.org/10.3917/gs.134.0123>
- Gires, C. (2018). *La prévention de la dénutrition du sujet âgé* (Sous-dochead Sarcopénie, dénutrition et fragilité chez la personne âgée). Récupéré de [https:// www. Science direct.com/science /article/pii/51766730518300743](https://www.ScienceDirect.com/science/article/pii/S1766730518300743)
- Haute Autorité de Santé. (2007, avril). *Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée* (Recommandation proffesionnelles). [https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/denutrition_personne_agee_2007 -_recommandations.pdf](https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/denutrition_personne_agee_2007_-_recommandations.pdf)
- Haute Autorité de la santé. (2014, Décembre). *Réponse à la saisine du 30 octobre 2014 en application de l'article L.161-39 du code de la sécurité sociale* (Repérage et évaluation des facteurs de risque de dépression chez les seniors de 55 ans et plus). [https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2015-02/argumentaire art 53 depression sujets ages vf 2015-02-16 15-33-53 53.pdf](https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2015-02/argumentaire_art_53_depression_sujets_ages_vf_2015-02-16_15-33-53_53.pdf)
- Haute Autorité de Santé. (2021). *Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus* (Recommander les bonnes pratiques). [https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/reco368 recommandations denutrition pa cd 20211110 v1.pdf](https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/reco368_recommandations_denutrition_pa_cd_20211110_v1.pdf)
- Henderson, V. (1994). La nature des soins infirmiers. Dans M-F. Collière (dir.). *Présentation des textes, Chronologie biographique, Notes explicatives* (pp.234-235) InterEditions.
- Ivernois, J-F. et Gagnayre, R. (dirs.). (1995). *Apprendre à éduquer le patient. Approche pédagogique*. Virgot

Laroque, G. (2010). Edito. *Gérontologie et société*, 33(134), 8-11.
<https://doi.org/10.3917/gs.134.0008>

Lenz, E., Pugh, L., Milligan, A., Gift, A. et Suppe, F. (1997). The middle range theory of unpleasant symptoms : An update. *Advance in Nursing Science*, 19 (3), 14-27.
Récupéré de
https://journals.lww.com/advancesinnursingscience/Abstract/1997/03000/The_Middle_Range_Theory_of_Unpleasant_Symptoms_An.3.aspx

Loi coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé, 10 mai 2015 :
Récupéré de : [http:// www.ejustice.just.fgov.be/cgi loi/loi a.pl](http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi loi/loi a.pl)

Malempré, G. et groupes CLAN des hôpitaux aigus. (2018). *Protocole du dépistage infirmier du risque de la dénutrition, de l'évaluation nutritionnelle et de la prise en charge de la dénutrition chez l'adulte hospitalisé* [protocole non publié]. Vivalia, Belgique

Melchior, J-C. (2001). Dénutritions et malnutritions. Dans A. Basdevant, M. Laville, et E. Lerebours (dirs.). *Traité de nutrition clinique de l'adulte* (pp. 381-391). Flammarion Médecine-sciences.

Meleis, A-I. (2010). Transitions Theory. *Middle-Range and Situation-Specific Theories in Nursing and Research and Practice*. Springer

Morel, M. (2012). Qualité des soins. Dans M. Formarier et L. Jovic (dirs.), *Les concepts en sciences infirmières* (2^{ème} éd.) (pp. 256-260). Association de Recherche en Soins Infirmiers. <https://doi.org/10.3917/arsi.forma.2012.01.0256>

Nestlé nutrition institute. (s.d.). *Mini Nutritional Assessment*. Récupéré de <https://www.mna-elderly.com/sites/default/files/2021-10/MNA-french.pdf>

Neurès, k. et Siebert, C. (dirs.). (2009). *Raisonnement démarche clinique et projet de soins*. Elsevier Masson.

Organisation Mondiale de la Santé. (1999). *Glossaire de la promotion de la santé*. Récupéré de https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67245/WHO_HPR_HEP_98.1_fre.pdf
f

- Paget, S. et Zara, S. (2016). Raisonnement et démarche Clinique infirmière. *De la discipline infirmière au modèle de Virginia Henderson*, 40-41. Récupéré de <https://www.ifsidijon.info/v2/wp-content/uploads/2015/09/2016-De-la-discipline-infirmiere-au-modele-de-V.-Henderson1.pdf>
- Pascal, A. et Frécon, E.(dirs). (2017). *Diagnostics infirmiers, interventions et résultats. Classifications infirmières et plan de soins* (6^{ème} éd.). Elsevier Masson SAS.
- Patry,C. et Raynaud-Simon, A. (2010). La dénutrition : quelles stratégies de prévention ? *Gérontologie et société*, 33 (134), 157-170. <https://doi.org/10.3917/g.s.134.0157>
- Référentiel de compétences professionnelles du Bachelier Infirmier Responsable de Soins Généraux* [Référentiel non publié]. (2019). Haute Ecole Robert Schuman, Libramont, Belgique.
- Rio, C., Lejeune, H., Jeannier, C., Noah, M., Amigon-Waterlot, S. et Szekely, C. (2018). *Alimentation et Alzheimer: S'adapter au quotidien*. Presses de l'EHESP.
- Sulmont-Rossé, C., Maître, I., Feyen, V., Vandenberghe-Descamps, M., Labouré, H., Feron, G. et Van wymelbeke, V. (2018). Quels aliments pour maintenir la prise alimentaire chez les personnes âgées et prévenir la dénutrition. *Innovations Agronomiques*, 65, 99-111. Récupéré de https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01899852/file/2018_Sulmont-Ross%C3%A9_Innovations%20Agronomiques.pdf
- Vanderwee, K., Clays, E., Bocquaert, I., Gobert, M., Folens, B. et Defloor, T. (2010). Malnutrition and associated factors in elderly hospital patients : A Belgian cross-sectional, multi-centre study. *Clinical Nutrition* 29 (4), 469-476.[https:// doi.org/10.1016/j.clnu.2009.12.013](https://doi.org/10.1016/j.clnu.2009.12.013)
- Vanmeerbeek, M. (2015). *Pour une vision intégrée du prévenir et du guérir*. <https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/186403/1/Pour%20une%20vision%20int%C3%A9gr%C3%A9e%20du%20pr%C3%A9venir%20et%20du%20gu%C3%A9rir.pdf>
- Vivalia. (s.d.). *Les fonctions de référence*. Récupéré de <https://www.vivalia.be/page/les-fonctions-de-reference>

Volkert, D., Beck, A-M., Cederholm, T., Cereda, E., Cruz-Jentoft, A., Goisser, S., De Groot, L., GroBhauser, F., Kiesswetter, E., Norman, K., Pourhassan, M., Reinders, L., Roberts, H., Rolland, Y., Schneider, S., Sieber, C., Thiem, U., Visser, M., Wijnhoven, H. et Wirth, R. (2019). Prise en charge de la malnutrition chez les patients-agés- Approches actuelles, données probantes et questions ouvertes. *Journal of Clinical Medicine*, 8 (7), 974. <https://doi103390/jcm8070974>

Annexes

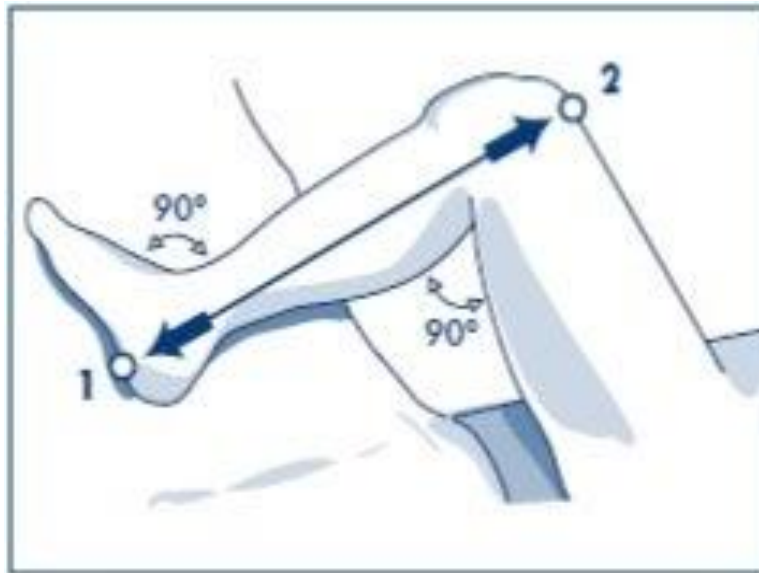
Annexe 1 : Echelle de dépistage initial infirmier de Madame C.

NRS 2002 (1 ^{ère} partie ou NRS 2002 initial)		
1. IMC <20,5 ?	Oui	<u>Non</u>
2. Perte de poids pendant les trois derniers mois ?	Oui	<u>Non</u>
3. Prise alimentaire diminuée pendant la semaine passée ?	Oui	<u>Non</u>
4. Le patient souffre-t-il d'une maladie sévère ?	<u>Oui</u>	Non

Annexe 2 : L'échelle de dépistage initial infirmier de Madame C. au cours de son hospitalisation.

NRS 2002 (1 ^{ère} partie ou NRS 2002 initial)		
1. IMC <20,5 ?	<u>Oui</u>	Non
2. Perte de poids pendant les trois derniers mois ?	<u>Oui</u>	Non
3. Prise alimentaire diminuée pendant la semaine passée ?	<u>Oui</u>	Non
4. Le patient souffre-t-il d'une maladie sévère ?	<u>Oui</u>	Non

Annexe 3 : l'équation de Chumlea



Année académique 2021-2022

Nous, soussignées MEGUEU TETSINA Vanette Valery et UMUGWANEZA UWASE Jeannette autorisons les membres de la Cellule d'Encadrement Méthodologique des Travaux de Fin d'Etudes à utiliser la version électronique de notre Travail de Fin d'Etudes et ce à des fins pédagogiques.

Date et signature(s) (précédé de la mention « Lu et approuvé »)

Lu et approuvé

Le 25 mai 2022

